Perfil V3 · código por código

Otorrinolaringología

Los 83 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Otorrinolaringología, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 33 códigos

6.03.1.001 Alergia nasosinusal

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.9 Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

QUÉ HAY QUE SABER

- Rinitis alérgica: estornudos en salva, rinorrea acuosa, prurito nasal/ocular y obstrucción; mucosa pálida y edematosa. Asocia asma y dermatitis atópica.
- Clasificación ARIA: intermitente (<4 días/semana o <4 semanas) vs persistente; leve vs moderada-severa (afecta sueño, trabajo o actividades).
- Leve intermitente: antihistamínico oral de 2ª generación (loratadina 10 mg/día, cetirizina 10 mg/día). Persistente o moderada-severa: corticoide intranasal (mometasona/fluticasona) diario, el más eficaz.
- Evitar alérgenos (ácaros, epitelios, pólenes), lavado nasal con suero fisiológico. No usar oximetazolina más de 5 días: rinitis medicamentosa.
- Diferencial: rinitis no alérgica (vasomotora, medicamentosa, hormonal) y rinosinusitis. Pruebas cutáneas o IgE específica si no responde o se plantea inmunoterapia.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 146**
>
> Un paciente de 8 años de edad, con historia de un año de evolución de rinorrea mucopurulenta bilateral intermitente asociado a prurito y en algunas ocasiones a epistaxis, actualmente sin síntomas. El tratamiento de elección en este caso es: **El tratamiento de elección en este caso es:**
>
> **A)** Antihistamínicos orales
> **B)** Antibióticos orales
> **C)** Corticoides tópicos
> **D)** Derivar a cirugía de adenoides
> **E)** Oximetazolina tópica
>
> Respuesta A. Es una rinitis alérgica intermitente, sin obstrucción: se trata con antihistamínicos orales. Los corticoides tópicos se reservan para cuando hay obstrucción nasal.

6.03.1.002 Amigdalitis aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.13 Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Faringoamigdalitis bacteriana (S. pyogenes): fiebre >38 °C, exudado amigdalino, adenopatías cervicales anteriores dolorosas, sin tos ni coriza; típico 5-15 años.
- Criterios de Centor/McIsaac orientan; tos, coriza, conjuntivitis o disfonía sugieren etiología viral (lo más frecuente, sobre todo <3 años).
- Tratamiento: penicilina benzatina 1.200.000 UI IM dosis única (600.000 UI si <27 kg) o amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días. Alergia: macrólido.
- Objetivo del antibiótico: prevenir fiebre reumática y complicaciones supuradas; analgesia con paracetamol o ibuprofeno.
- Diferencial: mononucleosis (adenopatías posteriores, esplenomegalia; amoxicilina da exantema). Trismus, voz de papa o desviación de úvula: absceso periamigdalino.

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 14.13

Un escolar de 7 años es traído a la consulta por fiebre de 38.6°C y odinofagia de 2 días de evolución. No tiene tos ni mucosidad nasal. Al examen físico destaca faringe eritematosa con amígdalas aumentadas de tamaño con exudado pultáceo y adenopatías cervicales anteriores bilaterales muy sensibles a la palpación. Según los criterios de Centor modificados por McIsaac, ¿cuántos puntos tiene y cuál es la conducta de elección?

A) 2 puntos; manejo puramente sintomático con paracetamol oral.
B) 3 puntos; solicitar hemograma con frotis y radiografía de tórax.
C) 5 puntos; iniciar tratamiento antibiótico con penicilina benzatina IM o amoxicilina oral por 10 días.
D) 4 puntos; iniciar ciprofloxacino oral por 5 días para evitar nefropatía.
E) 1 punto; indicar gárgaras con sal y citar a control en 7 días si persiste con fiebre.

Respuesta C. La opción correcta es la C. El paciente suma exactamente 5 puntos en la escala de McIsaac: fiebre > 38°C (+1), exudado amigdalino (+1), adenopatías anteriores sensibles (+1), ausencia de tos (+1) y edad de 3 a 14 años (+1). Con 5 puntos, la probabilidad de infección por Streptococcus pyogenes supera el 50-60%, estando formalmente indicado el inicio inmediato de tratamiento antibiótico de primera línea: Penicilina Benzatina intramuscular en dosis única o Amoxicilina oral (50 mg/kg/día) durante 10 días completos con el objetivo primordial de prevenir la fiebre reumática aguda.

6.03.1.003 Amigdalitis crónica

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.15 Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Amigdalitis crónica/recurrente: episodios repetidos documentados, halitosis, cáseum, adenopatías persistentes u odinofagia crónica.
- Criterios de Paradise para amigdalectomía: ≥7 episodios en 1 año, ≥5/año por 2 años o ≥3/año por 3 años.
- Otras indicaciones quirúrgicas: absceso periamigdalino recurrente, hipertrofia obstructiva con apnea del sueño, asimetría amigdalina sospechosa de neoplasia.
- Manejo inicial: tratar cada episodio agudo con penicilina/amoxicilina, higiene oral; registrar episodios para fundamentar la derivación.
- Derivar a otorrinolaringología para evaluar amigdalectomía; amígdala unilateral aumentada en adulto obliga a descartar linfoma o carcinoma.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 8 años con 8 episodios de faringoamigdalitis estreptocócica documentados y tratados en el último año, con ausentismo escolar importante. Entre episodios está asintomático. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Penicilina benzatina mensual indefinida
B) Tratar cada episodio y controlar sin otra medida
C) Derivar a otorrinolaringología para evaluar amigdalectomía
D) Amigdalectomía solo si presenta absceso periamigdalino
E) Solicitar ASO mensual

Respuesta C. La amigdalitis recurrente documentada con 7 o más episodios en 1 año, 5 o más por año en 2 años o 3 o más por año en 3 años (criterios de Paradise) indica evaluar amigdalectomía, al igual que el SAHOS por hipertrofia o el absceso periamigdalino recurrente. La penicilina profiláctica es para prevenir recurrencia de fiebre reumática.

6.03.1.004 Cáncer de boca, labios y orofaringe

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.20 Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Carcinoma escamoso en >90%; factores de riesgo: tabaco, alcohol, VPH-16 (orofaringe, pacientes más jóvenes), exposición solar (labio inferior).
- Sospechar ante úlcera, leucoplasia o eritroplasia oral que no cura en >2-3 semanas, odinofagia u otalgia refleja persistente, o adenopatía cervical dura.
- Eritroplasia tiene mayor riesgo de malignidad que leucoplasia; ambas requieren biopsia.
- Manejo inicial: suspender tabaco y alcohol, analgesia; no dar ciclos repetidos de antibiótico ante lesión que no cura.

- Derivar a otorrinolaringología o cabeza y cuello para biopsia y etapificación; adenopatía cervical en adulto fumador es cáncer hasta demostrar lo contrario.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 64 años, fumador de 40 paquetes-año y bebedor diario, consulta por una úlcera indolora de 1,5 cm, de bordes indurados, en el borde lateral izquierdo de la lengua, de 6 semanas de evolución. Hace 3 semanas se retiró una prótesis dental que la rozaba, pero la lesión no ha cicatrizado. No se palpan adenopatías cervicales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Enjuagues con clorhexidina y control en 3 meses
B) Cauterización con nitrato de plata
C) Aciclovir oral por 7 días
D) Nistatina en suspensión oral
E) Biopsia de la lesión

Respuesta E. Una úlcera, leucoplaquia o eritroplasia que no cicatriza en 2 semanas, sobre todo indurada, en el borde lateral de la lengua de un fumador y bebedor, es un carcinoma escamoso hasta demostrar lo contrario. Se biopsia y se deriva a cabeza y cuello para etapificar. Observar o tratar empíricamente retrasa el diagnóstico.

6.03.1.005 Cáncer laríngeo e hipofaríngeo

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.20 Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Carcinoma escamoso asociado a tabaco y alcohol; glótico da disfonía precoz (mejor pronóstico), supraglótico e hipofaríngeo debutan tarde con adenopatías.
- Banderas rojas: disfonía >3 semanas en mayor de 40 años fumador, disfagia, odinofagia, otalgia refleja, hemoptisis, estridor o adenopatía cervical.
- Toda disfonía persistente >3 semanas requiere visualización laríngea (laringoscopía) por especialista.
- Hipofaringe (seno piriforme): disfagia progresiva, otalgia refleja y masa cervical; diagnóstico tardío y peor pronóstico.
- Manejo inicial: cese de tabaco; si hay estridor o disnea, asegurar vía aérea. Derivar a otorrinolaringología para biopsia y TAC cervical.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 58

Un paciente de 61 años, fumador, consulta por disfonía de 2 meses de evolución, asociada a la aparición de una adenopatía cervical de consistencia aumentada. **¿Cuál es el examen inicial para el estudio de este paciente?**

A) Radiografías de cuello
B) Endoscopía digestiva alta
C) Nasofibroscopía
D) Ecografía de cuello
E) TAC de cuello

Respuesta C. La disfonía crónica se estudia con nasofibroscopía, más aún cuando se sospecha un cáncer de laringe, como en este fumador con adenopatía.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 7

Un paciente de 66 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por otalgia derecha, de algunos meses de evolución, asociado a odinofagia y disfagia, a lo que se le ha agregado atoramiento con algunos alimentos y cambios en la resonancia de la voz. **El diagnóstico más probable es:**

A) Cáncer de esófago
B) Disfunción temporomandibular
C) Cáncer de hipofaringe
D) Faringitis crónica
E) Cáncer de laringe

Respuesta C. Es un cáncer de hipofaringe clásico. El cáncer de laringe suele presentar disfonía progresiva, sin los otros síntomas, y el cáncer de esófago presenta disfagia sin los otros síntomas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 2

Un paciente de 58 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disfonía de 3 semanas de evolución, asociada a ligera odinofagia. Al examen físico, además, se palpa una adenopatía submandibular, de consistencia aumentada. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A) TAC de cuello
B) TAC de tórax
C) Ecografía de cuello
D) Nasofibrolaringoscopía
E) Endoscopía digestiva alta

Respuesta D. Toda disfonía crónica se estudia con nasofibrolaringoscopía. Además, el cuadro sugiere un cáncer de laringe, así que con mayor razón está indicada.

6.03.1.006 Cáncer nasosinusal

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.20 Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores raros; ocupacionales (polvo de madera: adenocarcinoma etmoidal; níquel, cuero). Escamoso es el más frecuente en seno maxilar.
- Sospechar ante síntomas nasales unilaterales en adulto: obstrucción progresiva, rinorrea sanguinolenta, epistaxis recurrente unilateral, cacosmia.
- Signos de extensión: proptosis, diplopía, epífora, hipoestesia infraorbitaria, dolor dental o aflojamiento de piezas, masa en paladar.
- Diferencial: pólipo antrocoanal, papiloma invertido, cuerpo extraño (niño). Unilateralidad persistente en adulto es la clave de alarma.
- Derivar a otorrinolaringología para nasofibroscopía, TAC/RM y biopsia; no tratar como sinusitis repetida.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 62 años, carpintero por 40 años, con obstrucción nasal izquierda progresiva de 4 meses, epistaxis unilateral recurrente, rinorrea fétida y parestesia de la mejilla izquierda. La rinoscopía muestra una masa friable en la fosa nasal izquierda. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Corticoide nasal y control en 3 meses
B) Antibiótico por sinusitis bacteriana
C) Cauterización de la epistaxis y alta
D) Derivación prioritaria a otorrinolaringología para TAC o RM de cavidades paranasales y biopsia por sospecha de cáncer nasosinusal
E) Polipectomía en atención primaria

Respuesta D. Síntomas nasales unilaterales y progresivos (obstrucción, epistaxis, rinorrea fétida) con signos de invasión (hipoestesia del infraorbitario, diplopía, proptosis) en un adulto mayor son banderas rojas de cáncer nasosinusal. La exposición a polvo de madera se asocia a adenocarcinoma etmoidal. Requiere imagen y biopsia. Los pólipos inflamatorios suelen ser bilaterales.

6.03.1.007 Diagnóstico diferencial de hipoacusias de transmisión

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.5 Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipoacusia de conducción: Rinne negativo (VO>VA) en oído afectado y Weber lateralizado hacia el oído enfermo.
- Causas: tapón de cerumen, cuerpo extraño, otitis externa, otitis media con efusión, perforación timpánica, colesteatoma, otoesclerosis.
- Otoscopía orienta: conducto ocupado, tímpano retraído/opaco con nivel, perforación o tímpano normal (otoesclerosis: mujer joven, progresiva, antecedente familiar).
- Audiometría: gap aéreo-óseo; impedanciometría: curva B (efusión), C (disfunción tubaria), As (otoesclerosis).

- Manejo inicial: resolver tapón de cerumen o tratar otitis; derivar a otorrinolaringología si persiste, hay perforación, colesteatoma o tímpano normal.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 35**
> Una paciente de 48 años consulta por hipoacusia bilateral de 10 años de evolución, progresiva, que aumentó especialmente durante su último embarazo. Su otoscopía es normal y el examen neurológico no muestra alteraciones vestibulares ni cerebelosas. Se realiza test de diapasones, que muestra prueba de Rinne negativo bilateral y prueba de Weber que no lateraliza. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
>
> **A)** Hipoacusia genética neurosensorial
> **B)** Ototoxicidad
> **C)** Otoesclerosis
> **D)** Hipoacusia hormonal
> **E)** Otitis media con efusión
>
> Respuesta C. El Rinne negativo habla de hipoacusia de conducción, y el Weber no lateraliza porque es bilateral y simétrica. Con otoscopía normal, curso lento de diez años y empeoramiento en el embarazo, es otoesclerosis. La otitis con efusión también es de conducción, pero se vería en la otoscopía.

6.03.1.008 Diagnóstico diferencial de hipoacusias sensorioneurales

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.5 Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber) · Tema 14.6 Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipoacusia sensorioneural: Rinne positivo (VA>VO) y Weber lateralizado al oído sano; audiometría con vía aérea y ósea descendidas juntas.
- Causas: presbiacusia (bilateral, simétrica, agudos), trauma acústico (escotoma en 4 kHz), ototóxicos, Ménière, sordera súbita, neurinoma del acústico.
- Hipoacusia unilateral asimétrica con tinnitus: descartar neurinoma del VIII par con resonancia magnética.
- Sordera súbita (<72 h) es urgencia: prednisona 1 mg/kg/día y derivación inmediata.
- GES: hipoacusia bilateral en ≥65 años con audífono; tratamiento de hipoacusia en prematuros. Derivar a ORL para audiometría y estudio.

PREGUNTAS (2)

> **Pregunta de práctica**
> Un paciente de 72 años consulta porque desde hace 3 años presenta dificultad para entender las conversaciones cuando asiste a reuniones familiares o en lugares con ruido de fondo, refiriendo que "oye pero no entiende". No tiene otalgia ni vértigo. La audiometría demuestra una hipoacusia sensorioneural bilateral y simétrica, con mayor caída en los tonos agudos (3000 a 8000 Hz) y caída de la discriminación de la palabra al 60%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el beneficio en el sistema de salud chileno?**
>
> **A)** Otoesclerosis bilateral; resolución quirúrgica con estapedectomía GES
> **B)** Presbiacusia; patología con Garantía Explícita en Salud (GES) con indicación de audífonos bilaterales
> **C)** Enfermedad de Ménière bilateral; tratamiento con restricción de sal y acetazolamida
> **D)** Trauma acústico crónico; derivación a mutualidad de seguridad laboral para indemnización
> **E)** Neurinoma del acústico bilateral; estudio genético urgente para Neurofibromatosis tipo 1
>
> Respuesta B. Es presbiacusia: hipoacusia sensorioneural bilateral, simétrica, en agudos, con mala discriminación en ambientes ruidosos. En Chile, la hipoacusia en personas de 65 años y más tiene GES, con confirmación diagnóstica, audífonos y rehabilitación.

Pregunta de práctica

Un hombre de 55 años consulta por hipoacusia del oído izquierdo de 2 semanas, sin dolor ni secreción. La otoscopía es normal en ambos oídos. Con el diapasón de 512 Hz, el Weber lateraliza hacia el oído derecho y el Rinne es positivo en ambos oídos. **¿Qué tipo de hipoacusia tiene y cómo la confirmarías?**

A) Hipoacusia de conducción izquierda; timpanometría
B) Hipoacusia de conducción derecha; audiometría
C) Hipoacusia sensorioneural izquierda; audiometría tonal
D) Audición normal; control en un mes
E) Tapón de cerumen izquierdo; lavado de oído

Respuesta C. El Weber se va al oído derecho, el sano, y el Rinne es positivo en ambos lados: es una hipoacusia sensorioneural del oído izquierdo. Se confirma con audiometría tonal, que debe mostrar ambas curvas descendidas sin brecha. Una hipoacusia de conducción izquierda daría Weber al izquierdo y Rinne negativo en ese oído.

6.03.1.009 Disfonías agudas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.16 Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke

QUÉ HAY QUE SABER

- Disfonía aguda (<3 semanas): laringitis viral asociada a resfrío es la causa más frecuente; también abuso vocal agudo.
- Tratamiento: reposo vocal, hidratación, humidificación, evitar tabaco e irritantes; analgesia. Antibióticos no indicados.
- Considerar reflujo laringofaríngeo (carraspeo, globus): IBP por 8 semanas y medidas antirreflujo.
- Banderas rojas: estridor, disnea, disfagia, hemoptisis, fumador mayor de 40 o persistencia >3 semanas: derivar para laringoscopía.
- Disfonía postquirúrgica (tiroidectomía) o tras intubación sugiere lesión del nervio laríngeo recurrente o trauma: evaluar por ORL.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 149

Una paciente de 27 años sufre atoro con un pedazo de alimento hace 7 días, que obstruyó la vía aérea y requirió maniobra de Heimlich para su desobstrucción. Desde entonces ha persistido con disfonía y carraspera. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar endoscopía digestiva alta
B) Solicitar radiografías de cuello
C) Solicitar TAC de cuello
D) Solicitar nasofibrolaringoscopía
E) Solicitar videodeglución

Respuesta D. Toda disfonía persistente se evalúa con nasofibrolaringoscopía. Además, el antecedente de cuerpo extraño y maniobra de Heimlich hace sospechar una lesión laríngea, una parálisis cordal o un cuerpo extraño residual, que se objetivan con este examen.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 149

Paciente de 27 años sufrió atoro con un trozo de alimento hace 7 días, que obstruyó la vía aérea y requirió maniobra de Heimlich para su desobstrucción. Desde entonces ha persistido con disfonía y carraspera. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar endoscopía digestiva alta
B) Solicitar radiografías de cuello
C) Solicitar TAC de cuello
D) Solicitar nasofibrolaringoscopía
E) Solicitar videodeglución

Respuesta D. Una disfonía que persiste tras un evento laríngeo (cuerpo extraño, maniobras de desobstrucción, intubación) puede deberse a lesión de cuerdas vocales, hematoma, restos de cuerpo extraño o luxación aritenoidea. El examen de elección es la visualización directa de la laringe mediante nasofibrolaringoscopía. Las imágenes y la endoscopía digestiva no evalúan la movilidad cordal.

6.03.1.010 Disfonías crónicas

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.16 Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke

QUÉ HAY QUE SABER

- Disfonía crónica: >3 semanas; obliga a visualizar la laringe para descartar cáncer, especialmente en fumadores mayores de 40 años.
- Causas: nódulos vocales (bilaterales, profesionales de la voz), pólipo, edema de Reinke (fumadora), quiste, parálisis cordal, reflujo, carcinoma.
- Parálisis de cuerda vocal: buscar lesión del recurrente (cirugía tiroidea, tumor pulmonar o mediastínico, aneurisma aórtico).
- Manejo inicial: suspender tabaco, higiene vocal, tratar reflujo; no prolongar tratamiento empírico sin laringoscopía.
- Derivar a otorrinolaringología para laringoscopía; nódulos se manejan con fonoaudiología, pólipos y lesiones sospechosas con cirugía/biopsia.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 103

Un paciente de 30 años presenta disfonía persistente, de un mes de evolución, que inició al asistir a un concierto de rock.
¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nódulos vocales
B) Disfonía musculotensional
C) Cáncer de laringe
D) Pólipos vocales
E) Reflujo faringo-laríngeo

Respuesta D. Los pólipos pueden producirse de forma aguda: al forzar mucho la voz hay una hemorragia en la cuerda que evoluciona a un pólipo. Los nódulos y la disfonía musculotensional se forman por abuso vocal crónico. A los treinta años el cáncer de laringe es muy improbable.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 2 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 58 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disfonía de 3 semanas de evolución, asociada a ligera odinofagia. Al examen físico, además, se palpa una adenopatía submandibular, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el examen más adecuada para proseguir el estudio?

A) TAC de cuello
B) TAC de tórax
C) Ecografía de cuello
D) Nasofibrolaringoscopía
E) Endoscopía digestiva alta

Respuesta D. Toda disfonía crónica se estudia con NFC. En este caso, además, el cuadro clínico sugiere cáncer de laringe, así que con mayor razón está indicada la NFC.

6.03.1.011 Epistaxis a repetición

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.11 Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Epistaxis recurrente: generalmente anterior en área de Kiesselbach; en niños por manipulación digital, rinitis y sequedad.
- Buscar causas: HTA, anticoagulantes/antiagregantes, coagulopatía (von Willebrand), telangiectasia hemorrágica hereditaria, tumor (nasoangiofibroma en adolescente varón).
- Manejo: compresión digital 10-15 minutos, vasoconstrictor tópico, cauterización química con nitrato de plata del punto sangrante, lubricación nasal.
- Solicitar hemograma y pruebas de coagulación si es recurrente o hay sangrado en otros sitios.
- Derivar a ORL si es unilateral persistente, adolescente varón con obstrucción nasal, sospecha tumoral o falla de cauterización.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 9 años con episodios de epistaxis anterior derecha 2 a 3 veces por semana en el último mes, autolimitados con compresión, especialmente en invierno. Se rasca la nariz con frecuencia. Al examen hay vasos prominentes y costras en el área de Kiesselbach derecha. Sin hematomas ni otros sangrados, hemograma normal. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Taponamiento posterior
B) Humectación nasal (vaselina o suero), evitar el rascado y cauterización química con nitrato de plata del área de Kiesselbach si persiste
C) Estudio de coagulación completo y derivación a hematología de inmediato
D) Ligadura de la arteria esfenopalatina
E) TAC de cavidades paranasales

Respuesta B. La epistaxis recurrente anterior en niños se origina en el plexo de Kiesselbach, favorecida por sequedad, rascado y rinitis. Se maneja con humectación, tratamiento de la rinitis y cauterización con nitrato de plata de los vasos visibles. Se estudia coagulación ante sangrados en otros sitios, antecedentes familiares o anemia; en un adolescente varón con epistaxis unilateral grave, sospechar nasoangiofibroma.

6.03.1.012 Epistaxis leve

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.11 Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Epistaxis leve: 90% anterior (plexo de Kiesselbach), autolimitada; más frecuente en niños y con aire seco.
- Primer paso: paciente sentado, cabeza inclinada hacia adelante, compresión bidigital de alas nasales 10-15 minutos sin soltar.
- Si persiste: algodón con vasoconstrictor (oximetazolina) y anestésico, luego cauterización con nitrato de plata; si falla, taponamiento anterior.
- Evaluar estabilidad hemodinámica y presión arterial; no inclinar la cabeza hacia atrás (deglución de sangre y aspiración).
- Prevención: lubricación con vaselina o suero, evitar manipulación digital; derivar si es recurrente o no cede.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 71 años, hipertenso con tratamiento irregular, llega a urgencia con sangrado nasal bilateral abundante de 1 hora. Está pálido y sudoroso, con PA 190/105 mmHg y FC 105 lpm. Tras compresión digital durante 15 minutos y taponamiento anterior bilateral con Merocel, sigue cayendo sangre roja abundante por la pared posterior de la orofaringe, con tos y arcadas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Nitrato de plata en ambos lados del tabique
B) Cambiar el Merocel y dar de alta con control en 48 horas
C) Taponamiento posterior con sonda Foley, tapón anterior, hospitalización y antibiótico profiláctico
D) Pedir cabeza hacia atrás y observación en el box
E) Solo antihipertensivos orales y observar en casa

Respuesta C. Es una epistaxis posterior, probablemente de la arteria esfenopalatina en un adulto mayor hipertenso. Falló el tapón anterior y hay sangre fresca en la orofaringe. Se coloca Foley con 8 a 10 mL de agua, más tapón anterior ipsilateral; se hospitaliza con monitorización, se piden hemograma y pruebas de coagulación, se controla la presión y se da amoxicilina con clavulánico.

6.03.1.013 Estridor laríngeo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.17 Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Estridor: ruido por obstrucción de vía aérea; inspiratorio sugiere supraglotis/glotis, bifásico subglotis, espiratorio tráquea intratorácica.
- Lactante con estridor inspiratorio que empeora en decúbito supino y llanto, desde las primeras semanas: laringomalacia (causa más frecuente, benigna).

- Agudo: laringitis obstructiva (crup, tos perruna; dexametasona 0,15-0,6 mg/kg y adrenalina nebulizada si moderado-severo), cuerpo extraño, epiglotitis, angioedema.
- Signos de gravedad: retracción, cianosis, alteración de conciencia, sialorrea, posición en trípode; no explorar faringe si se sospecha epiglotitis.
- Derivar a ORL/broncopulmonar para nasofibroscopía si es crónico, progresivo, con mal incremento ponderal, apneas o cianosis.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 86**
>
> Lactante con estridor desde el nacimiento, cuya causa es una laringomalacia. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Control sano habitual
> **B)** Derivar a especialista
> **C)** Hospitalizar
> **D)** Observación domiciliaria
> **E)** Iniciar tratamiento empírico
>
> Respuesta A. La laringomalacia es la causa más frecuente de estridor congénito: estridor inspiratorio que aumenta en decúbito supino y con el llanto. En las formas leves, sin apneas, cianosis ni mal incremento ponderal, se maneja en el control sano habitual, porque se resuelve sola hacia los 12 a 18 meses.

6.03.1.014 Hipoacusia neonatal

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.21 Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Factores de riesgo: prematurez, UCI neonatal >5 días, hiperbilirrubinemia, TORCH (CMV), ototóxicos, malformaciones craneofaciales, antecedente familiar.
- Tamizaje universal con emisiones otoacústicas (o PEAT automatizado en riesgo) antes del alta; GES: hipoacusia bilateral del prematuro.
- Si falla, repetir; si falla nuevamente, potenciales evocados auditivos de tronco (PEAT) para confirmar antes de los 3 meses.
- Meta 1-3-6: tamizaje al mes, diagnóstico a los 3 meses, intervención (audífonos/implante coclear) antes de los 6 meses.
- Sospecha clínica: no reacciona a ruidos, no balbucea o retraso del lenguaje; derivar a ORL infantil ante tamizaje alterado.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 92**
>
> Lactante que llega sin test de audición a su primer control. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Emisiones otoacústicas
> **B)** Impedanciometría
> **C)** Evaluación por fonoaudiología
> **D)** Audiometría
> **E)** Reflejo cocleopalpebral
>
> Respuesta A. El examen de tamizaje auditivo universal en el recién nacido es la medición de emisiones otoacústicas. Los potenciales evocados quedan para cuando esta prueba sale alterada, no como primera opción.

6.03.1.015 Masa cervical

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.20 Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Niño: generalmente inflamatoria (adenitis reactiva) o congénita (quiste tirogloso en línea media que asciende con la lengua, quiste branquial lateral).
- Adulto >40 años: masa cervical persistente >2-3 semanas es neoplasia (metástasis de carcinoma escamoso, linfoma, tiroides) hasta demostrar lo contrario.

- Banderas rojas: dura, fija, indolora, >2 cm, supraclavicular, crecimiento progresivo, síntomas B, disfonía, disfagia u otalgia refleja.
- Manejo inicial: si es inflamatoria, antibiótico y control en 2-3 semanas; no repetir ciclos antibióticos indefinidamente.
- Derivar a ORL/cabeza y cuello: nasofibroscopía, ecografía o TAC y PAAF; evitar biopsia excisional antes de examinar vía aerodigestiva.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 92

Un paciente de 18 años consulta por odinofagia intensa de 2 días asociada a fiebre hasta 38,5 °C y aumento de volumen doloroso submandibular derecho. Tiene faringe congestiva con amígdala derecha aumentada y exudado purulento. Se palpa una masa blanda y dolorosa, con eritema, de 4 cm en la zona submandibular derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Absceso periamigdalino
B) Mononucleosis infecciosa
C) Quiste branquial infectado
D) Adenitis supurada
E) Linfoma de Hodgkin

Respuesta D. Es una amigdalitis bacteriana complicada con una adenitis supurada submandibular. El absceso periamigdalino se caracteriza por dolor muy intenso, trismus y abombamiento del pilar amigdalino, que aquí no aparecen.

Pregunta de práctica

Un hombre de 62 años, fumador crónico, consulta por una masa en la región lateral izquierda del cuello de 4 semanas de evolución, indolora y pétrea, de 3 cm. Refiere además otalgia refleja izquierda ocasional con otoscopía normal. **¿Cuál es el método de elección para la confirmación anatomopatológica y cuál procedimiento está formalmente contraindicado?**

A) Elección: biopsia incisional abierta en pabellón. Contraindicada: PAAF bajo ecografía
B) Elección: PAAF guiada por ecografía. Contraindicada: biopsia ganglionar abierta antes de descartar un tumor primario en la vía aérea superior
C) Elección: aspiración con trócar grueso por sospecha de quiste sebáceo. Contraindicada: tomografía computarizada
D) Elección: exéresis de urgencia de la glándula tiroides. Contraindicada: nasofibroscopía flexible
E) Elección: cefadroxilo oral por 21 días. Contraindicada: evaluación por otorrinolaringólogo

Respuesta B. En un fumador mayor de 40 años, una masa cervical pétrea es una metástasis de carcinoma escamoso hasta demostrar lo contrario. La PAAF guiada por ecografía es el método citológico de primera línea y no disemina células. Está prohibida la biopsia abierta del ganglio sin evaluar antes la vía aérea superior y sin PAAF.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 31 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 35 años, que cursa una infección respiratoria alta, presenta aparición de aumento de volumen cervical progresivo, de localización suprahioidea. A la palpación, se constata consistencia gomosa y se observa que asciende al solicitarle a la paciente que protruya la lengua. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nódulo 2roideo
B) Quiste dermoide
C) Adenopaaa cervical
D) Quiste del conducto 2rogloso
E) Linfoma

Respuesta D. Es un quiste del conducto Grogloso clásico. La ubicación en la línea media, suprahioidea es lo más característico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 75 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 23 años consulta por aumento de volumen en el cuello, que ha aumentado lentamente de tamaño en los últimos meses. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, en la línea media, ubicado entre el mentón y el cartílago tiroides, de 3 cm de diámetro y consistencia blanda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Quiste branquial
B) Adenitis supurada
C) Quiste del conducto tirogloso
D) Adenoma de glándula salival submandubilar
E) Quiste epidermoide

Respuesta D. Diagnóstico: Adenoma de glándula salival submandubilar (opción D). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

6.03.1.016 Obstrucción nasal crónica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.12 Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

QUÉ HAY QUE SABER

- Causas: desviación septal, hipertrofia de cornetes, rinitis alérgica/medicamentosa, pólipos, hipertrofia adenoidea (niño) y tumores.
- Unilateral: desviación septal, pólipo antrocoanal, cuerpo extraño (niño, rinorrea fétida) o tumor; bilateral: rinitis, poliposis, adenoides.
- Rinitis medicamentosa por uso de vasoconstrictor tópico >5-7 días: suspender y usar corticoide intranasal.
- Manejo inicial: corticoide intranasal y lavados salinos si hay componente inflamatorio; tratar la rinitis alérgica de base.
- Derivar a ORL si persiste pese a tratamiento, es unilateral, hay sangrado o sospecha anatómica (septoplastía, adenoidectomía).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 32 años consulta por obstrucción nasal derecha constante de varios años, que no fluctúa, sin estornudos, prurito ni rinorrea. En la adolescencia tuvo un golpe en la nariz. A la rinoscopía anterior, el tabique está desviado hacia la derecha y contacta el cornete inferior; en la fosa izquierda hay hipertrofia del cornete inferior. No hay pólipos. **¿Cuál es el tratamiento definitivo?**

A) Oximetazolina nasal diaria
B) Septoplastia electiva, con turbinoplastia del cornete hipertrófico
C) Polipectomía endoscópica
D) Antihistamínicos orales por 3 meses
E) Amoxicilina con ácido clavulánico por 14 días

Respuesta B. Obstrucción unilateral, fija y constante tras un trauma, con tabique desviado, es una desviación septal. Los corticoides intranasales alivian el componente mucoso, pero la corrección definitiva es la septoplastia electiva, asociando turbinoplastia del cornete compensatorio. Los descongestionantes de uso crónico producen rinitis medicamentosa.

6.03.1.017 Odinofagias agudas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.13 Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Odinofagia aguda: casi siempre faringoamigdalitis, mayoritariamente viral; considerar S. pyogenes si fiebre, exudado, adenopatías anteriores y ausencia de tos.
- Tratamiento bacteriana: penicilina benzatina 1.200.000 UI IM única o amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días; viral: sintomático.
- Otras causas: mononucleosis, herpangina (vesículas en paladar blando), candidiasis, esofagitis (odinofagia retroesternal en inmunodeprimido).
- Banderas rojas: trismus, sialorrea, voz apagada, desviación de úvula, tortícolis o disnea: absceso periamigdalino, retrofaríngeo o epiglotitis.

- Control si no mejora en 48-72 horas; derivar ante sospecha de absceso o compromiso de vía aérea.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Una mujer de 24 años consulta por odinofagia de 2 días, con temperatura de 37,8 °C, rinorrea, tos, disfonía y conjuntivas enrojecidas. Al examen tiene faringe eritematosa sin exudado y no hay adenopatías cervicales dolorosas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Amoxicilina oral por 10 días
> **B)** Penicilina benzatina intramuscular
> **C)** Tratamiento sintomático, hidratación y consulta si aparecen signos de alarma
> **D)** Hemograma y serología para virus Epstein-Barr
> **E)** Azitromicina oral por 5 días
> Respuesta C. La mayoría de las odinofagias agudas son virales. Tos, rinorrea, disfonía y conjuntivitis orientan a virus, y con McIsaac de 0 no se estudia ni se dan antibióticos: solo sintomáticos. Se educa en signos de alarma: trismus, sialorrea, voz apagada, disnea o fiebre que persiste más de 3 a 5 días.

6.03.1.018 Odinofagias crónicas

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.20 Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Odinofagia >3 semanas en adulto, sobre todo fumador y bebedor, debe hacer sospechar cáncer de orofaringe, hipofaringe o laringe supraglótica.
- Asociar: otalgia refleja, disfagia, baja de peso, halitosis, adenopatía cervical o úlcera que no cura.
- Otras causas: reflujo laringofaríngeo, amigdalitis crónica, candidiasis, esofagitis infecciosa o por fármacos, tiroiditis subaguda.
- No prolongar tratamientos antibióticos empíricos; manejo inicial sintomático y suspensión de tabaco y alcohol.
- Derivar a ORL para nasofibroscopía y eventual biopsia; si hay disfagia esofágica, endoscopía digestiva alta.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 60 años, fumador de 40 paquetes-año y bebedor intenso, con odinofagia derecha de 2 meses, otalgia refleja derecha y baja de 6 kg de peso. No tiene fiebre. Se palpa una adenopatía cervical derecha dura de 3 cm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Amoxicilina por 10 días y control
> **B)** Ecografía tiroidea
> **C)** Inhibidor de bomba de protones por reflujo
> **D)** Antiinflamatorios y control en 3 meses
> **E)** Derivación prioritaria a otorrinolaringología para nasofibrolaringoscopía y biopsia por sospecha de cáncer de orofaringe, hipofaringe o laringe
> Respuesta E. La odinofagia persistente (más de 3 semanas), unilateral, con otalgia refleja, baja de peso y adenopatía cervical dura en un fumador y bebedor es un carcinoma escamoso de cabeza y cuello hasta demostrar lo contrario. Requiere examen endoscópico, biopsia de la lesión primaria y TAC cervical con contraste. No se debe tratar empíricamente con antibióticos de forma reiterada.

6.03.1.019 Otitis externa

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.3 Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Otitis externa difusa: P. aeruginosa y S. aureus; otalgia intensa que aumenta con tracción del pabellón o presión del trago, otorrea, conducto edematoso.
- Factores: humedad ("oído de nadador"), manipulación con cotonitos, audífonos, dermatitis.
- Tratamiento: gotas de ciprofloxacino con corticoide (dexametasona/hidrocortisona) por 7-10 días, analgesia y mantener oído seco; aseo del conducto.
- Otomicosis (Aspergillus, Candida): prurito, detritus con esporas; aseo y antifúngico tópico (clotrimazol).

- Otitis externa maligna: diabético o inmunodeprimido, otalgia nocturna intensa, granulación en conducto, parálisis facial: hospitalizar, TAC y antibiótico EV antipseudomonas; derivar.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 160

Un niño de 6 años presenta prurito en el oído derecho desde hace 3 días, al que ayer se agregó otalgia intensa. Al examen físico, presenta dolor intenso a la compresión del trago y, en la otoscopía, se observa edema del conducto auditivo y presencia de secreción amarillenta. El tímpano se observa sin perforación, de aspecto grisáceo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Forunculosis del conducto auditivo externo
B) Otitis externa
C) Otitis media aguda
D) Colesteatoma
E) Candidiasis del oído

Respuesta B. Otitis externa clásica, de tipo difuso, probablemente por Pseudomonas aeruginosa. Se trata con ciprofloxacino tópico. La otomicosis por Candida produce prurito, con poco dolor y secreción grumosa blanquecina.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 170

Un niño de 9 años presenta otalgia de dos días de evolución, con secreción por el conducto auditivo, sin mal olor. Al examen físico se aprecia dolor a la tracción del pabellón auricular, con conducto auditivo estrecho, que dificulta la otoscopía, siendo imposible visualizar el tímpano. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Otitis externa
B) Tapón de cerumen
C) Otitis media crónica
D) Cuerpo extraño ótico
E) Otitis media aguda perforada

Respuesta A. El dolor a la tracción del pabellón sugiere otitis externa. No suele haber mal olor, porque Pseudomonas no lo produce, y un conducto estrecho es factor de riesgo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 46

Un paciente de 35 años consulta por otalgia izquierda de 3 días de evolución, asociada a otorrea ipsilateral. El dolor aumenta al traccionar el pabellón auricular. A la otoscopía se observa el conducto auditivo externo edematoso, con escasa secreción y tímpano normal. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A) Amoxicilina oral
B) Ciprofloxacino tópico
C) Amoxicilina más ácido clavulánico oral
D) Neomicina tópica
E) Antiinflamatorios orales

Respuesta B. Otitis externa difusa: primera línea ciprofloxacino tópico. La neomicina también tiene evidencia con el tímpano intacto, y solo está contraindicada si hay perforación, por ototoxicidad; la pregunta se resolvió a favor del ciprofloxacino.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 157

Un paciente de 35 años consulta por prurito en el oído izquierdo, asociado a secreción blanquecina y sensación de oído tapado. A la otoscopía se observa abundante secreción grumosa que cubre parcialmente el tímpano. **¿Cuál es el tratamiento de elección para iniciar el manejo de este paciente?**

A) Ciprofloxacino tópico
B) Fluconazol oral
C) Clotrimazol tópico
D) Amoxicilina oral
E) Ciprofloxacino oral

Respuesta C. Otomicosis por Candida albicans: se trata con un antimicótico tópico, como clotrimazol.

Pregunta de práctica

Una mujer de 78 años, diabética de larga data con mal apego al tratamiento, consulta por otalgia derecha intensa de predominio nocturno, refractaria a paracetamol y tramadol, con otorrea purulenta fétida. En la otoscopía hay edema del conducto con tejido de granulación eritematoso en el piso, en la unión osteocartilaginosa. Presenta desviación de la comisura bucal hacia la izquierda y lagoftalmos derecho. **¿Cuál es el examen inicial de elección para evaluar la extensión ósea?**

A) Radiografía simple de cráneo en proyección de Schüller
B) TAC de peñasco y base de cráneo con contraste
C) Resonancia magnética de encéfalo sin contraste
D) Ecografía de partes blandas de la región parotídea
E) Audiometría y potenciales evocados auditivos de tronco

Respuesta B. Otitis externa maligna con parálisis del VII par. El TAC de peñasco y base de cráneo con contraste define la osteólisis. La radiografía simple tiene poca resolución, y la resonancia complementa después las partes blandas endocraneales.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 102 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 7 años presenta otalgia derecha, asociada a otorrea. Al examinarlo presenta otorrea, sin olor y a la otoscopía presenta canal auditivo estrecho, por lo que no es posible ver el tímpano. Además presenta dolor al traccionar el pabellón auricular. EL diagnóstico más probable es:

A) Otitis media aguda
B) Otitis media crónica
C) Otitis externa
D) Tapón de cerumen
E) Otomastoiditis aguda

Respuesta C. Diagnóstico: Otitis externa (opción C). Cuadro clásico (aunque pudieron haberlo descrito mejor).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 167 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente se pone un piercing en la oreja, sin embargo evoluciona con dolor y eritema, por lo que se la retira. Al sacar el piercing no ha mejorado y, en cambio, el pabellón auricular se observa eritematoso y aumentado de volumen, como se ve en la siguiente imagen (fuente:): ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Streptococcus pyogenes
B) Staphylococcus aureus
C) Streptococcus agalactiae
D) Staphylococcus epidirmidis
E) Pseudomona aureginosa

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Pseudomona aureginosa). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del pa

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 113 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con piercing en oreja; al retirarlo persiste aumento de volumen y eritema en la zona. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Pseudomonas aeruginosa
B) Staphylococcus aureus
C) Streptococcus pyogenes
D) Candida albicans
E) Mycobacterium fortuitum

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Pseudomonas aeruginosa). Pseudomonas aeruginosa. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan c

6.03.1.020 Otitis media aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.1 Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: otalgia/fiebre aguda más tímpano abombado, eritematoso, opaco e inmóvil a la otoscopía neumática; agentes: neumococo, H. influenzae, M. catarrhalis.
- Tratamiento: amoxicilina 80-90 mg/kg/día cada 12 horas, 10 días si <2 años o severa (5-7 días en mayores), más paracetamol o ibuprofeno.
- Si no mejora en 48-72 horas: cambiar a amoxicilina-ácido clavulánico; alérgicos: macrólido (claritromicina o azitromicina).
- OMA perforada: otorrea purulenta con alivio del dolor; mismo antibiótico oral, mantener oído seco; puede agregarse gota de ciprofloxacino.
- Banderas rojas: retroauricular eritematoso, pabellón desplazado, parálisis facial, cefalea, vértigo o meningismo: complicación, derivar urgente.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Un niño de 18 meses, previamente sano y con vacunas al día, consulta por fiebre de 39,2 °C axilar de 24 horas, llanto inconsolable y manos hacia la oreja derecha. Tuvo un resfrío común hace 5 días en la sala cuna. Está febril, reactivo y sin signos meníngeos. La otoscopía izquierda es normal; en el oído derecho el tímpano está francamente abombado, eritematoso, opaco y sin movilidad, sin otorrea. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Amoxicilina 80 a 90 mg/kg/día cada 12 horas por 10 días y analgesia con paracetamol o ibuprofeno
B) Gotas óticas de ciprofloxacino con corticoide por 7 días
C) Solo analgesia y observación por 48 horas, sin antibióticos
D) Antihistamínico y descongestionante nasal por 7 días
E) Derivación urgente para miringotomía y timpanocentesis

Respuesta A. Es una OMA severa: menor de 2 años, fiebre sobre 39 °C y tímpano abombado con hipomovilidad. Corresponde amoxicilina en dosis alta por 10 días más analgesia. Las gotas óticas no atraviesan un tímpano íntegro, los antihistamínicos no sirven, y la miringotomía se reserva para las complicaciones.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 128 · texto original del banco, sin revisar

Niño con antecedente de resfrío de 1 semana que inicia con otorrea y otalgia, a la otoscopia secreción purulenta, no se visualiza tímpano:

A) Amoxicilina
B) Amoxicilina/ Ac. clavulánico
C) Ciprofloxacino tópico
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Amoxicilina). La otitis media aguda es una infección bacteriana del oído medio muy frecuente en niños y menos frecuente en adultos. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

6.03.1.021 Otitis media con efusión

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.2 Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Efusión en oído medio sin signos de infección aguda; frecuente tras OMA o con disfunción tubaria/hipertrofia adenoidea. Se manifiesta como hipoacusia de conducción.
- Otoscopía: tímpano opaco, retraído, con nivel hidroaéreo o burbujas; impedanciometría con curva tipo B.
- No indicar antibióticos, corticoides, antihistamínicos ni descongestionantes; observar 3 meses (12 semanas), la mayoría se resuelve espontáneamente.
- Derivar a ORL si persiste >3 meses, hipoacusia significativa, retraso del lenguaje o cambios estructurales del tímpano: colleras ± adenoidectomía.
- Adulto con efusión unilateral persistente: descartar tumor de nasofaringe (cavum) con nasofibroscopía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 35

Niño de 8 años con otorrea crónica serosa, hipoacusia conductiva bilateral y tímpano con perforación central. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A) Gotas óticas de ciprofloxacino + taponamiento con algodón
B) Miringoplastia electiva
C) Timpanotomía de urgencia
D) Audiometría y derivación a otorrinolaringología
E) Antibiótico oral por 14 días

Respuesta D. Perforación timpánica crónica con hipoacusia de conducción: audiometría para cuantificar la pérdida y derivación a otorrinolaringología para evaluar la timpanoplastia. No se tapona un oído perforado.

6.03.1.022 Otitis media crónica y complicaciones

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.2 Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa · Tema 14.4 Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis

QUÉ HAY QUE SABER

- OMC simple: perforación timpánica central con otorrea intermitente indolora; colesteatomatosa: perforación marginal/atical, otorrea fétida persistente y destructiva.
- Colesteatoma es quirúrgico: erosiona huesecillos, conducto del facial, laberinto y tegmen.
- Manejo inicial de la reagudización: aseo del conducto, gotas de ciprofloxacino (no ototóxicas, evitar aminoglucósidos), mantener oído seco.
- Complicaciones: mastoiditis, parálisis facial, laberintitis/fístula (vértigo), meningitis, absceso cerebral y trombosis del seno sigmoideo.
- Derivar a ORL: TAC de oídos sin contraste y cirugía (timpanoplastía, mastoidectomía); derivación urgente ante cualquier complicación.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 148

Un paciente de 47 años, con antecedente de perforación timpánica derecha de larga data, presenta otalgia y otorrea de dos días de evolución. Al examen físico, la otoscopía muestra la perforación timpánica conocida, con presencia de secreción amarillenta en relación al tímpano y al conducto auditivo externo. **¿Qué antibiótico es de elección para el tratamiento inicial de este paciente?**

A) Neomicina tópica
B) Ciprofloxacino tópico
C) Amoxicilina oral
D) Amoxicilina con ácido clavulánico oral
E) Ceftriaxona endovenosa

Respuesta B. Otitis media crónica simple reagudizada: primera línea tópica con ciprofloxacino. La neomicina es un aminoglucósido, con riesgo de ototoxicidad con el tímpano perforado. Los antibióticos sistémicos se reservan para los casos complicados.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 153

Paciente de 45 años con otorrea crónica recurrente, hipoacusia conductiva y perforación timpánica central con colesteatoma evidenciado en TAC de oídos. **¿Cuál es el tratamiento?**

A) Timpanomastoidectomía (cirugía)
B) Antibióticos tópicos indefinidos
C) Corticoides tópicos
D) Audífonos
E) Solo observar

Respuesta A. Colesteatoma: tratamiento quirúrgico obligatorio, timpanomastoidectomía, para erradicarlo y prevenir mastoiditis, meningitis y parálisis facial.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 35

Niño de 8 años con otorrea crónica serosa, hipoacusia conductiva bilateral y tímpano con perforación central. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A) Gotas óticas de ciprofloxacino + taponamiento con algodón
B) Miringoplastia electiva
C) Timpanotomía de urgencia
D) Audiometría y derivación a otorrinolaringología
E) Antibiótico oral por 14 días

Respuesta D. Perforación timpánica crónica con hipoacusia de conducción: audiometría para cuantificar la pérdida y derivación a otorrinolaringología para evaluar la timpanoplastia. No se tapona un oído perforado.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 104

Un paciente de 59 años presenta hipoacusia bilateral, asociado a otorrea, de larga data. Consulta por un cuadro de reciente inicio, de mayor hipoacusia derecha, asociada a vértigo persistente, que ha ido en aumento. Al examen se aprecia nistagmo horizontal, con fase rápida a derecha. **El diagnóstico más probable es:**

A) Otomastoiditis aguda
B) Laberintitis aguda
C) Vértigo postural paroxístico
D) Absceso cerebral
E) Neuronitis vestibular

Respuesta B. Otorrea crónica con hipoacusia, más vértigo persistente y nistagmo de reciente inicio: laberintitis aguda, complicación de la otitis media crónica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 84

Un paciente de 45 años, con historia de años de evolución de hipoacusia y supuración por oído derecho, consulta por compromiso del estado general, fiebre hasta 39 °C, vértigo y secreción ótica purulenta. Al examen se aprecia nistagmus horizontal con fase rápida a izquierda, a la otoscopía solo se aprecia secreción purulenta en conducto auditivo externo, no se observa tímpano. **El tratamiento más adecuado en este caso es:**

A) Antibióticos endovenosos
B) Lavado ótico
C) Cirugía de urgencia
D) Corticoides endovenosos
E) Antiinflamatorios endovenosos

Respuesta A. Laberintitis aguda con fiebre y mal estado general: lo primero es antibiótico endovenoso, igual que en la mastoiditis. La cirugía se evalúa caso a caso, por ejemplo si es secundaria a un colesteatoma. Es una pregunta discutible.

Pregunta de práctica

Un niño de 2 años presenta fiebre de 39,3 °C, irritabilidad y tumefacción retroauricular izquierda dolorosa y eritematosa que desplaza el pabellón hacia adelante y borra el surco retroauricular. La otoscopía muestra el tímpano izquierdo abombado e hiperémico. **¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica inicial más adecuada?**

A) Amoxicilina con ácido clavulánico oral por 14 días y control ambulatorio en 48 horas
B) Ecografía de partes blandas y alta con antiinflamatorios
C) Hospitalizar de inmediato, TAC de peñasco con contraste e iniciar ceftriaxona endovenosa
D) Drenaje por punción ambulatoria y cefadroxilo oral
E) Gotas óticas de ciprofloxacino y radiografía simple de cráneo

Respuesta C. Mastoiditis aguda: urgencia que exige hospitalización, TAC de peñasco con contraste y ceftriaxona endovenosa, con evaluación por otorrinolaringología. El manejo ambulatorio con antibióticos orales no corresponde.

6.03.1.023 Patología de glándulas salivales

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.19 Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo

QUÉ HAY QUE SABER

- Parotiditis viral (paperas): tumefacción parotídea bilateral dolorosa, puede complicarse con orquitis, meningitis o pancreatitis; manejo sintomático.
- Parotiditis bacteriana (S. aureus): adulto mayor deshidratado o postoperado; pus por conducto de Stenon; hidratación, sialogogos y antibiótico antiestafilocócico.
- Sialolitiasis: más frecuente en submandibular; dolor y aumento de volumen prandial.

- Tumores: 80% parotídeos y la mayoría benignos (adenoma pleomorfo, Warthin); parálisis facial, dolor, fijación o crecimiento rápido sugieren malignidad.
- Diferencial: Sjögren (bilateral crónico, xeroftalmía) y VIH. Derivar a ORL/cabeza y cuello: ecografía, PAAF; no hacer biopsia incisional parotídea.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 71

Un paciente de 38 años con cuadro de 6 meses con aumento de volumen en región preauricular derecha. Al examen físico se constata nódulo en región preauricular de 4 cm de diámetro, de consistencia blanda, indoloro a la palpación y fija, sin afectación de la piel que lo recubre. **El diagnóstico más probable:**

A) Adenopatía tuberculosa
B) Adenoma pleomorfo
C) Lipoma
D) Quiste sebáceo
E) Sarcoma

Respuesta B. La ubicación preauricular sugiere un tumor de la parótida, y el adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente de esa glándula. Además, el cuadro es indoloro, de crecimiento lento y sin compromiso de la piel.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 178

Un paciente de 50 años consulta por aumento de volumen en la región masetérica izquierda, de crecimiento lento y consistencia dura. Al examen físico se palpa un tumor de 2 cm de diámetro, ubicado sobre la rama mandibular izquierda, de consistencia aumentada. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Lipoma
B) Rabdomiosarcoma
C) Adenopatía preauricular
D) Tumor de parótida
E) Quiste sebáceo

Respuesta D. Un tumor ubicado en esa zona sugiere un tumor de parótida. Los tumores benignos son más frecuentes que los malignos, y la parálisis facial y las adenopatías tumorales sugieren malignidad.

Pregunta de práctica

Un paciente de 50 años consulta por dolor y aumento de volumen agudo recurrente en la región submandibular derecha, que aparece típicamente al comenzar a comer y cede gradualmente 2 horas después. La palpación bimanual del piso de la boca revela una zona indurada milimétrica dolorosa a lo largo del trayecto del conducto salival. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el conducto excretor involucrado?**

A) Parotiditis viral urliana; conducto de Stenon
B) Sialolitiasis submandibular; conducto de Wharton
C) Adenoma pleomorfo submandibular; conducto de Rivinus
D) Ranula sublingual simple; conducto de Bartolino
E) Angina de Ludwig inicial; conducto tirogloso persistente

Respuesta B. El dolor y el aumento de volumen desencadenados por la comida, el cólico salival, son propios de la sialolitiasis. La mayoría de los cálculos se forman en la glándula submandibular y se impactan en el conducto de Wharton.

Pregunta de práctica

Un hombre de 82 años, hospitalizado hace 5 días tras una cirugía abdominal mayor, en ayuno prolongado y con mala higiene oral, presenta fiebre de 38,9 °C y dolor intenso con aumento de volumen eritematoso y caliente de la región preauricular derecha. Tiene trismus leve. Al exprimir la glándula hacia adelante sale pus franco por la mucosa yugal, frente al segundo molar superior. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Extracción transoral del cálculo con anestesia local
B) Hidratación endovenosa y cloxacilina endovenosa
C) Parotidectomía superficial con preservación del nervio facial
D) Sialogogos con gotas de limón y calor local
E) Enucleación simple de la masa

Respuesta B. Es una parotiditis bacteriana aguda supurada, por vía ascendente a través del conducto de Stenon, en un paciente deshidratado. Se trata con hospitalización, rehidratación endovenosa y antibiótico antiestafilocócico, como cloxacilina o cefazolina.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 168 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 6 años es traído por su madre, dado que desde hace 2 horas comenzó con dolor y aumento de volumen en la zona paro`dea derecha. Al examen físico se palpa la glándula parótida derecha aumentada de tamaño, dolorosa a la compresión. Al interrogatorio, la madre refiere que desde los 4 años ha presentado cuatro episodios similares, que han respondido al tratamiento con analgésicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Sjögren
B) Paro2di2s viral recurrente
C) Li2asis del conducto de Stensen
D) Paro2di2s crónica
E) Tumor paroadeo

Respuesta C. Es una sialolitiasis clásica. La obstrucción produce dolor y aumento de volumen súbitos. La desobstrucción puede ser intermitente. El tratamiento suele ser con analgésico y, si se ve el cálculo a la salida del conducto salival, es posible retirarlo.

6.03.1.024 Poliposis nasal

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.12 Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

QUÉ HAY QUE SABER

- Rinosinusitis crónica con pólipos: obstrucción nasal bilateral, hiposmia/anosmia y rinorrea; pólipos grisáceos, translúcidos, insensibles y móviles.
- Asocia asma y enfermedad respiratoria exacerbada por AINE (tríada de Samter: asma, pólipos, intolerancia a aspirina).
- Pólipo nasal en niño: descartar fibrosis quística (test del sudor). Pólipo unilateral en adulto: descartar papiloma invertido o tumor.
- Manejo inicial: corticoide intranasal y lavados salinos; curso corto de corticoide oral en casos severos.
- Derivar a ORL para nasofibroscopía, TAC de cavidades perinasales y eventual cirugía endoscópica.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 58

Un paciente, con antecedente de rinitis alérgica, presenta obstrucción nasal marcada, asociada varios episodios de sinusitis en el último tiempo. Respira por la boca, por la obstrucción nasal. En la rinoscopía anterior, se visualizan numerosos pólipos en la mucosa, de aspecto pálido y brillante, que obstruyen completamente las fosas nasales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar fluticasona tópica c/12 horas
B) Iniciar prednisona oral 1 mg/Kg/día por 7 días
C) Solicitar TAC de cavidades paranasales
D) Realizar cirugía endoscópica nasal
E) Solicitar niveles plasmáticos de inmunoglobulinas

Respuesta B. En una poliposis bilateral con obstrucción completa se parte con un ciclo breve de corticoide oral. El corticoide intranasal se asocia después; la cirugía queda para los casos refractarios.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 118 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente, con antecedente de rinitis alérgica, presenta marcada obstrucción nasal marcada, asociada varios episodios de sinusitis en el último tiempo. En la rinoscopía anterior, se visualizan numerosos pólipos en la mucosa, de aspecto pálido y brillante. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar fluticasona tópica
B) Iniciar prednisona oral
C) Solicitar TAC de cavidades paranasales
D) Realizar cirugía endoscópica nasal
E) Solicitar niveles plasmáticos de inmunoglobulinas

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar prednisona oral (opción B). La poliposis nasal se trata con corticoides orales.. Tratamiento inicial: corticoides orales porque el spray no llega por la obstrucción; luego corticoides intranasales permanentes De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

6.03.1.025 Rinorrea crónica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.9 Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

QUÉ HAY QUE SABER

- Rinorrea >12 semanas: rinitis alérgica, rinitis no alérgica (vasomotora, gustatoria, del adulto mayor), rinosinusitis crónica o medicamentosa.
- Rinorrea acuosa unilateral clara, que aumenta al inclinarse, post-trauma o cirugía: sospechar fístula de LCR (beta-2 transferrina); derivar.
- Unilateral purulenta fétida en niño: cuerpo extraño; en adulto: sinusitis odontogénica o tumor.
- Manejo inicial: lavados salinos, corticoide intranasal; bromuro de ipratropio intranasal en rinitis vasomotora con rinorrea acuosa predominante.
- Derivar a ORL si es unilateral, sanguinolenta, refractaria o con sospecha de fístula o tumor.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 79

Un paciente de 80 años consulta por rinorrea bilateral, de tres meses de evolución, muy molesta, asociada a congestión nasal, que es más intensa en las mañanas y aumenta con los cambios de temperatura. **El diagnóstico más probable es:**

A) Cáncer nasal
B) Pólipos nasales
C) Sinusitis bacteriana crónica
D) Rinitis vasomotora
E) Rinitis alérgica

Respuesta D. Rinitis vasomotora: empeora en la mañana y con los cambios de temperatura, también con el estrés y los alimentos muy calientes o condimentados. El cáncer da obstrucción y rinorrea serosanguinolenta unilateral, y los pólipos son bilaterales con marcada obstrucción, en pacientes jóvenes.

6.03.1.026 Rinorreas agudas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.10 Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Rinofaringitis viral (resfrío común) es la causa más frecuente: autolimitado 7-10 días; manejo sintomático, sin antibióticos.
- Sospechar rinosinusitis bacteriana si: síntomas >10 días sin mejoría, inicio severo (fiebre ≥39 °C y rinorrea purulenta ≥3 días) o doble empeoramiento.
- Tratamiento bacteriana: amoxicilina (niños 80-90 mg/kg/día; adultos 500 mg-1 g c/8-12 h) por 7-10 días; si falla, amoxicilina-clavulánico.
- Coadyuvantes: lavado nasal con suero fisiológico, corticoide intranasal; no se necesita radiografía para el diagnóstico.
- Banderas rojas: edema/eritema periorbitario, proptosis, diplopía, cefalea intensa o compromiso de conciencia: complicación orbitaria o intracraneal, derivar urgente.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 139

Un paciente de 17 años consulta por un cuadro que inició hace 12 días, consistente en congestión nasal, rinorrea mucosa abundante y odinofagia. En los últimos días la rinorrea se vuelve purulenta y empeoran los síntomas, agregándose sensación febril y tos seca mayor en las noches. Al examen físico se constata fiebre de 38,2 °C, FC 78 por minuto, FR 12 por minuto, faringe eritematosa con descarga posterior y rinorrea purulenta en ambas fosas nasales. Su examen cardiopulmonar es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Amoxicilina oral por 7 días
B) Claritromicina oral por 10 días
C) Aseo con suero fisiológico
D) Corticoides orales por 7 días
E) Antihistamínicos orales por 7 días

Respuesta A. Síntomas que superan los 10 días y además empeoran, con fiebre y rinorrea purulenta, definen una rinosinusitis aguda bacteriana. La primera línea es amoxicilina; los macrólidos quedan para alérgicos a penicilina. Los lavados nasales son coadyuvantes, no reemplazan al antibiótico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 143 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 26 años, presenta un cuadro de 5 días de rinorrea, que a los dos días se vuelve mucopurulenta, agregándose odinofagia, y congestión nasal. Al examen físico se aprecia rinorrea, asociada a eritema y congestión faríngea. Se solicita una radiografía de senos paranasales que muestra velamiento de ambos senos maxilares. El tratamiento más adecuado es:

A) Amoxicilina oral
B) Amoxicilina más ácido clavulánico oral
C) Corticoide tópico
D) Descongestionantes tópicos
E) Antihistamínicos orales

Respuesta A. Es una sinusitis aguda. Por el tiempo de evolución es probablemente viral y no requiere sino tratamiento sintomático. Sin embargo, no aparecía dentro de las alternativas y lo que se pregunta entonces es el tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda, que de primera línea es con amoxicilina. Los descongestionantes tópicos, no son muy indicados, ya que tienen efectos adversos y no solucionan los de

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 66 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 5 años consulta por un cuadro de 7 días de evolución de rinorrea purulenta, descarga posterior, cefalea, fiebre y obstrucción nasal. En el último tiempo se agrega mayor fiebre, más edema y eritema periocular derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Queratoconjuntivitis viral
B) Absceso periorbitario
C) Conjuntivitis bacteriana
D) Sinusitis maxilar
E) Absceso frontal

Respuesta D. [Pregunta disputada] Es una mala pregunta. En estricto rigor parece una celulitis preorbitaria, que no estaba en las opciones, secundaria a una sinusitis (no queda claro si es maxilar, etmoidal o frontal). Tampoco parace un absceso orbitario (no existe el concepto periorbitario), por no tener limitación a la movilización de los movimientos, proptosis o otras alteraciones similares.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 118 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 5 años presenta un cuadro de 7 días de fiebre, cefalea, rinorrea purulenta abundante, descarga posterior y obstrucción nasal. Desde hace poco se agrega mayor fiebre, además de edema y eritema periocular derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Absceso frontal
B) Conjuntivitis bacteriana
C) Sinusitis maxilar
D) Absceso periorbitario
E) Conjuntivitis viral

Respuesta D. Diagnóstico: Absceso periorbitario (opción D). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

6.03.1.027 Síndrome de apnea del sueño

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.15 Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Adulto: ronquido, apneas presenciadas, somnolencia diurna (Epworth), cefalea matinal; factores: obesidad, cuello ancho, HTA refractaria, retrognatia.
- Niño: ronquido, apneas, respiración bucal, enuresis, déficit atencional y mal rendimiento; causa principal hipertrofia adenoamigdalina.
- Diagnóstico confirmatorio con polisomnografía (IAH ≥5 con síntomas o ≥15); poligrafía respiratoria domiciliaria en adultos de alta probabilidad.
- Complicaciones: HTA, arritmias, ACV, accidentes de tránsito; manejo inicial: baja de peso, evitar alcohol y sedantes, higiene del sueño.
- Derivar a ORL/broncopulmonar: CPAP en adultos moderado-severo; adenoamigdalectomía en niños con hipertrofia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 14.15

Un niño de 5 años presenta ronquidos nocturnos de 6 meses de evolución y pausas respiratorias nocturnas documentadas por sus padres de hasta 15 segundos con despertares sobresaltados y sudoración profusa. En el día respira con la boca abierta y presenta retraso pondoestatural. Al examen orofaríngeo se observan amígdalas palatinas grado 4 de Brodsky que contactan en la línea media. ¿Cuál es la conducta médica de elección más indicada?

A) Tratamiento prolongado con antibióticos orales profilácticos por 6 meses.
B) Indicación quirúrgica de adenoamigdalectomía bilateral.
C) Uso exclusivo de descongestionantes nasales tópicos nocturnos.
D) Observación expectante hasta los 12 años esperando la involución fisiológica espontánea.
E) Tratamiento con estimulantes del sistema nervioso central para la hiperactividad.

Respuesta B. La opción correcta es la B. El paciente presenta un Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) infantil severo con repercusión en el desarrollo físico y amígdalas grado 4 que colapsan la orofaringe. El SAHOS pediátrico documentado secundario a hipertrofia de amígdalas y adenoides es la indicación quirúrgica absoluta indiscutida de adenoamigdalectomía. Postergar la intervención quirúrgica (opción D) expone al niño a fallo de medro, alteraciones ortodóncicas craneofaciales irreversibles y riesgo de hipertensión pulmonar / cor pulmonale crónico.

6.03.1.028 Síndrome respirador bucal

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.15 Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Niño que respira por la boca: causas principales hipertrofia adenoidea, hipertrofia amigdalina y rinitis alérgica.
- Facies adenoidea: boca abierta, cara alargada, paladar ojival, maloclusión, ojeras; asocia ronquido, apneas, voz hiponasal y OME recurrente.
- Estudio: radiografía lateral de cavum para evaluar tamaño adenoideo; buscar apneas del sueño.
- Manejo inicial: corticoide intranasal y tratamiento de la rinitis alérgica; lavados nasales.
- Seguimiento: si persiste obstrucción, apneas u otitis recurrente, adenoidectomía ± amigdalectomía; coordinar con ortodoncia y fonoaudiología.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 48

Un niño de 7 años, respirador bucal, es traído por su madre. No presenta apnea del sueño ni infecciones a repetición. Al examen físico no tiene obstrucción nasal y se observa faringe con amígdalas grado II. Se solicita radiografía de cavum, que constata hipertrofia adenoidea con 80% de obstrucción. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Desloratadina oral
B) Fluticasona intranasal
C) Adenoidectomía
D) Observar evolución y controlar ambulatoriamente
E) Solicitar TAC de cavidades paranasales

Respuesta D. Sin apnea, sin infecciones recurrentes y sin complicaciones, no hay indicación quirúrgica: se observa. La hipertrofia adenoidea involuciona con la edad. La cirugía se reserva para SAHOS u otras complicaciones.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 141 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 6 años consulta por epistaxis bilateral frecuent

E) Además, tiene antecedente de ser respirador bucal, roncar en la noche y presentar infecciones respiratorias altas a repetición. El diagnóstico más probable es:

A) Rinofibroangioma bilateral
B) Rinitis alérgica
C) Enfermedad de von Willebrand
D) Hipertrofia de adenoides

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Además, tiene antecedente de ser respirador bucal, roncar en la noche y presentar infecciones respiratorias altas a repetición. El diagnóstico más probable es:). El respirador bucal es un motivo de consulta frecuente en pediatría y otorrinolaringología. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

6.03.1.029 Síndrome vertiginoso

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.7 Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière

QUÉ HAY QUE SABER

- Diferenciar vértigo periférico (intenso, nistagmo horizontal-rotatorio unidireccional que se inhibe con la fijación, síntomas auditivos) de central.
- VPPB: segundos, desencadenado por cambios de posición, Dix-Hallpike positiva; Ménière: horas con hipoacusia fluctuante, tinnitus y plenitud; neuronitis: días, sin hipoacusia.
- Banderas rojas centrales: HINTS central, nistagmo vertical o cambiante, ataxia, diplopía, disartria, cefalea, factores de riesgo vascular.
- Manejo inicial: sedantes vestibulares por pocos días (dimenhidrinato, tietilperazina); maniobra de Epley en VPPB del canal posterior.
- Derivar a ORL para estudio vestibular y audiometría; sospecha central: imagen y neurología urgente.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 168

Un paciente de 35 años presenta un golpe en la cabeza, debido a una caída a nivel, hace un mes. Desde entonces ha presentado reiterados episodios de vértigo intenso, de segundos de duración, que aparece con algunos movimientos de la cabeza. No tiene síntomas auditivos y su examen neurológico muestra movilidad coordinada y conservada, sin alteraciones de la marcha ni del examen de pares craneanos. Los síntomas se reproducen con las maniobras de Dix-Hallpike. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Difenidol 25 mg al día por 7 días
B) Betahistina 8 mg cada 12 horas por 1 mes
C) Solicitar prueba calórica
D) Solicitar resonancia magnética nuclear de troncoencéfalo y cerebro
E) Realizar maniobras de reposición vestibular

Respuesta E. Vértigo de segundos gatillado por movimientos de la cabeza, sin síntomas auditivos ni focalidad, con Dix-Hallpike positivo: VPPB (el traumatismo de cráneo puede desprender otoconias). Se trata con maniobras de reposición (Epley); no se indican fármacos ni neuroimágenes.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 154

Paciente de 50 años con episodios de vértigo rotatorio, tinnitus unilateral fluctuante e hipoacusia neurosensorial ipsilateral. Los síntomas duran horas. Audiometría disponible en una semana. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Ménière
B) Vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB)
C) Neuritis vestibular
D) ACV de fosa posterior
E) Schwannoma vestibular

Respuesta A. Vértigo episódico de horas, con hipoacusia neurosensorial y tinnitus fluctuantes del mismo lado: enfermedad de Menière. El VPPB dura segundos y no tiene hipoacusia; la neuronitis dura días y no tiene síntomas auditivos.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 137

Paciente con vértigo posicional y maniobra de Dix-Hallpike positiva para canal posterior izquierdo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Betahistina oral por 4 semanas
B) Dimenhidrinato oral por 7 días
C) Maniobras de reposición canalicular (Epley)
D) Derivar a neurología urgente
E) Prednisona oral 1 mg/kg/día

Respuesta C. Vértigo posicional con Dix-Hallpike positivo: VPPB del canal posterior. La conducta de primera línea es la maniobra de reposición canalicular de Epley.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 7

Un paciente presenta vértigo, de segundos de duración, que se le produce al girar la cabeza a derecha, mientras está acostado. No tiene síntomas auditivos y como antecedente refiere haber sufrido un traumatismo encefálico hace 10 días, en un accidente de trabajo. No presenta adiadococinesia ni dismetría. El resto de su examen físico es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar flunarizina
B) Iniciar tietilperazina
C) Solicitar un TAC de oídos
D) Derivar para maniobras de reposición vestibular
E) Iniciar difenidol

Respuesta D. Es un vértigo postural paroxístico benigno clásico, aquí postraumático: segundos de duración, gatillado por el giro de la cabeza y sin síntomas auditivos. Se trata con maniobras de reposición vestibular, no con fármacos.

6.03.1.030 Sinusopatías crónicas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.10 Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Rinosinusitis crónica: ≥12 semanas con ≥2 síntomas (obstrucción, rinorrea anterior/posterior, dolor facial, hiposmia), uno obstrucción o rinorrea, más evidencia endoscópica o TAC.
- Se divide en con y sin pólipos; factores: rinitis alérgica, asma, alteraciones anatómicas, origen odontogénico (unilateral maxilar).
- Tratamiento inicial: lavados nasales salinos de alto volumen y corticoide intranasal por 8-12 semanas.
- Estudio: TAC de cavidades perinasales (no radiografía) cuando falla el tratamiento médico o se plantea cirugía.
- Derivar a ORL si es refractaria, unilateral, poliposa o con complicaciones: cirugía endoscópica funcional.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 69

Paciente de 43 años presenta obstrucción nasal marcada, asociada a rinorrea de 5 años de evolución, con sensación de presión facial, cefalea e hiposmia. La radiografía de cavidades paranasales muestra velamiento de ambos senos maxilares. La TAC de cavidades paranasales muestra secreciones e inflamación de la mucosa de ambos senos maxilares y de las celdillas etmoidales bilaterales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Fluticasona nasal
B) Azitromicina
C) Cirugía endoscópica nasal
D) Rinomanometría
E) Resonancia magnética nuclear de cavidades paranasales

Respuesta A. Síntomas nasosinusales de más de 12 semanas (obstrucción, rinorrea, presión facial, hiposmia) con compromiso mucoso en la TAC definen rinosinusitis crónica. El tratamiento de primera línea son los corticoides intranasales y los lavados nasales con solución salina. La cirugía endoscópica se reserva para la falla del tratamiento médico máximo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 117 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente con un cuadro de 5 años de evolución de marcada obstrucción nasal y rinorrea acuosa. Se realiza una radiografía de cavidades paranasales, que muestra velamiento de los senos maxilares. Se solicita un TAC de cavidades paranasales que muestra engrosamiento de la mucosa de los senos etmoidales y maxilares. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar fluticasona tópica
B) Realizar cirugía endoscópica nasal
C) Solicitar rinomanometría
D) Indicar tratamiento antibiótico
E) Iniciar antihistamínicos orales

Respuesta A. Parecía una rinitis crónica, con predominio de síntomas obstructivos, por lo que de primera línea se deben indicar corticoides tópicos.

6.03.1.031 Tinitus

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.6 Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Tinnitus subjetivo es lo más frecuente; suele asociarse a hipoacusia sensorioneural (presbiacusia, trauma acústico, ototóxicos).
- Siempre evaluar con audiometría; tinnitus unilateral con hipoacusia asimétrica: descartar neurinoma del acústico con RM.
- Tinnitus pulsátil: sospechar causa vascular (paraganglioma, malformación, hipertensión intracraneana); requiere imagen.
- Otras causas: tapón de cerumen, Ménière (con vértigo e hipoacusia fluctuante), salicilatos, aminoglucósidos.
- Manejo inicial: tranquilizar, retirar ototóxicos, evitar ruido, manejar ansiedad/insomnio; derivar a ORL para estudio y audífonos si hay hipoacusia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 55 años con tinnitus en el oído izquierdo de 6 meses, asociado a hipoacusia progresiva del mismo lado y leve inestabilidad. La otoscopía es normal. La audiometría muestra hipoacusia sensorioneural izquierda con discriminación de palabras desproporcionadamente baja. **¿Cuál es el estudio más adecuado?**

A) Ninguno; indicar enmascaradores de ruido
B) TAC de oídos sin contraste
C) Resonancia magnética de conductos auditivos internos y ángulo pontocerebeloso con gadolinio
D) Ecografía Doppler carotídea
E) Impedanciometría

Respuesta C. El tinnitus unilateral con hipoacusia sensorioneural asimétrica y mala discriminación es la forma de presentación típica del schwannoma vestibular (neurinoma del acústico). Debe estudiarse con resonancia magnética con gadolinio de conductos auditivos internos. El tinnitus pulsátil orienta a causas vasculares. El tinnitus bilateral con presbiacusia simétrica no requiere imágenes.

6.03.1.032 Trastorno de deglución

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

QUÉ HAY QUE SABER

- Disfagia orofaríngea (dificultad para iniciar la deglución, tos o atoro, regurgitación nasal) vs esofágica (sensación de detención retroesternal).
- Orofaríngea: ACV, Parkinson, ELA, miastenia, divertículo de Zenker (halitosis, regurgitación de alimentos no digeridos).
- Esofágica: sólidos progresiva sugiere obstrucción mecánica (cáncer, estenosis péptica); sólidos y líquidos desde inicio, trastorno motor (acalasia).
- Banderas rojas: baja de peso, progresión, anemia, edad >45, odinofagia, hematemesis; neumonías aspirativas.

- Derivar: endoscopía digestiva alta en disfagia esofágica; nasofibroscopía, videofluoroscopía y evaluación fonoaudiológica en disfagia orofaríngea.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 75 años, 3 semanas después de un ACV isquémico, presenta tos y voz húmeda al beber líquidos, y tuvo una neumonía hace 1 semana. Está alerta y cooperador. **¿Cuál es la conducta más adecuada para evaluar la deglución?**
> **A)** Evaluación fonoaudiológica de la deglución y estudio instrumental (videofluoroscopía o evaluación endoscópica de la deglución)
> **B)** Endoscopía digestiva alta
> **C)** Manometría esofágica
> **D)** Radiografía de tórax de control solamente
> **E)** Indicar gastrostomía de inmediato
> Respuesta A. La tos o voz húmeda con líquidos y la neumonía aspirativa tras un ACV indican disfagia orofaríngea con aspiración. Se evalúa con tamizaje y evaluación fonoaudiológica, y se confirma con videofluoroscopía o FEES, que definen consistencias seguras y maniobras compensatorias. La endoscopía digestiva y la manometría evalúan la disfagia esofágica.

6.03.1.033 Trastornos de habla y lenguaje

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.2 Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hitos: balbuceo 6 meses, primeras palabras 12 meses, frases de 2 palabras a los 24 meses; inteligible para extraños a los 4 años.
- Retraso del lenguaje: siempre descartar hipoacusia con audiometría o potenciales evocados, aunque el tamizaje neonatal haya sido normal.
- Diferencial: trastorno del espectro autista (alteración de la interacción social), discapacidad intelectual, trastorno específico del lenguaje, deprivación.
- Dislalias (sustitución de fonemas) son esperables hasta los 4-5 años; la disfluencia transitoria es frecuente en preescolares.
- Derivar a fonoaudiología y neurología/ORL infantil ante retraso significativo, regresión o sospecha de TEA; control en programa de salud infantil.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Niño de 2 años y medio en control sano. Su madre refiere que dice solo 8 palabras aisladas y no combina 2 palabras. Comprende órdenes simples, mira a los ojos, juega con otros niños e imita. El examen físico es normal y no tiene antecedentes perinatales relevantes. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**
> **A)** Tranquilizar y controlar a los 4 años
> **B)** Electroencefalograma
> **C)** Resonancia magnética cerebral
> **D)** Evaluación auditiva (descartar hipoacusia) y derivación a fonoaudiología
> **E)** Iniciar metilfenidato
> Respuesta D. A los 2 años se esperan al menos 50 palabras y frases de 2 palabras. Un retraso del lenguaje expresivo requiere primero descartar hipoacusia con evaluación auditiva objetiva (potenciales evocados o audiometría según edad), además de evaluar desarrollo global y signos de trastorno del espectro autista, y derivar a fonoaudiología para estimulación precoz.

Situaciones clínicas de urgencia 18 códigos

6.03.2.001 Absceso mastoídeo de otitis media aguda y crónica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.4 Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Mastoiditis aguda: complicación de OMA, más frecuente en niños; dolor, eritema y edema retroauricular, pabellón desplazado hacia adelante y abajo, fiebre.
- Absceso subperióstico: fluctuación retroauricular; absceso de Bezold en cuello (esternocleidomastoideo) en adultos.
- Manejo inicial: hospitalizar, antibiótico endovenoso (ceftriaxona ± cloxacilina; cubrir Pseudomonas si OMC), analgesia.
- TAC de oídos con contraste para evaluar absceso y complicaciones intracraneales (trombosis del seno sigmoideo, absceso cerebral, meningitis).
- Derivar urgente a ORL para drenaje, miringotomía/colleras o mastoidectomía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 2 años presenta fiebre de 39,3 °C, irritabilidad y tumefacción retroauricular izquierda dolorosa y eritematosa que desplaza el pabellón hacia adelante y borra el surco retroauricular. La otoscopía muestra el tímpano izquierdo abombado e hiperémico. **¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica inicial más adecuada?**

A) Amoxicilina con ácido clavulánico oral por 14 días y control ambulatorio en 48 horas
B) Ecografía de partes blandas y alta con antiinflamatorios
C) Hospitalizar de inmediato, TAC de peñasco con contraste e iniciar ceftriaxona endovenosa
D) Drenaje por punción ambulatoria y cefadroxilo oral
E) Gotas óticas de ciprofloxacino y radiografía simple de cráneo

Respuesta C. Mastoiditis aguda: urgencia que exige hospitalización, TAC de peñasco con contraste y ceftriaxona endovenosa, con evaluación por otorrinolaringología. El manejo ambulatorio con antibióticos orales no corresponde.

6.03.2.002 Absceso periamigdalino

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.14 Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Complicación de faringoamigdalitis en adolescente/adulto joven: odinofagia unilateral intensa, fiebre, trismus, voz de papa y sialorrea.
- Examen: abombamiento del pilar anterior y paladar blando unilateral con desviación de la úvula al lado contrario.
- Diferencial: flegmón periamigdalino (sin colección, solo antibiótico); si sospecha extensión profunda, TAC cervical con contraste.
- Tratamiento: punción-aspiración o incisión y drenaje, más antibiótico (penicilina sódica o clindamicina EV, luego amoxicilina-clavulánico o clindamicina oral) por 10-14 días, analgesia e hidratación.
- Recurrencia o amigdalitis recurrente asociada: amigdalectomía diferida (4-6 semanas); hospitalizar si hay compromiso de vía aérea o no tolera oral.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 48

Hombre de 20 años con odinofagia severa, fiebre 39°C, dificultad para abrir la boca (trismus) y desviación de la úvula hacia el lado contrario. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Angina de Ludwig
B) Faringitis estreptocócica
C) Absceso periamigdalino
D) Mononucleosis infecciosa
E) Epiglotitis

Respuesta C. Odinofagia severa, trismus y úvula desviada al lado contrario: absceso periamigdalino, un proceso unilateral de la faringe. La angina de Ludwig es bilateral, del piso de la boca, de origen dental, con lengua protruida.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 119

Un paciente está en el tercer día de tratamiento con azitromicina, por una amigdalitis con exudado. Consulta por aumento de la odinofagia, asociada a imposibilidad de comer por trismo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Absceso periamigdalino
B) Angina de Ludwig
C) Mononucleosis infecciosa
D) Absceso parafaríngeo
E) Absceso retrofaríngeo

Respuesta A. Amigdalitis con exudado que empeora pese al antibiótico y suma trismo: absceso periamigdalino, la complicación supurativa clásica de la amigdalitis.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 170 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 23 años consulta por odinofagia intensa, asociada a fiebre, que han empeorado y que y en el último tiempo se agrega dificultades para comer, por trismus. Al examen físico presenta eritema faríngeo, exudado amigdalino bilateral y abomba- miento del pilar diafragmático derecho. El diagnóstico más probable es:

A) Absceso retrofaríngeo
B) Angina de Ludwig
C) Amigdalitis ulcero-necrótica
D) Absceso periamigdalino
E) Mononucleosis infecciosa

Respuesta D. Diagnóstico: Absceso periamigdalino (opción D). Es un absceso periamigdalino clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 148 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con contractura de músculos masticatorios con úvula desplazada. rigidez de nuca esbozada, dolor cervical, gran exudado de amígdalas bilaterales:

A) Absceso retrofaringeo
B) Flegmon periamigdalina
C) Absceso peritonsila
D) Absceso retrotonsilar
E) Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Absceso peritonsila). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Absceso retrofaringeo, Flegmon periamigdalina) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paci

6.03.2.003 Absceso profundo de cuello

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.14 Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Infecciones de espacios profundos (parafaríngeo, submandibular): origen dental, amigdalino o ganglionar; mayor riesgo en diabéticos e inmunodeprimidos.
- Angina de Ludwig: celulitis submandibular bilateral de origen dental, lengua elevada, piso de boca indurado; riesgo inminente de obstrucción de vía aérea.
- Clínica: fiebre, odinofagia, trismus, tortícolis, aumento de volumen cervical, disnea o estridor.
- Manejo inicial: asegurar vía aérea, hospitalizar, antibiótico EV de amplio espectro (ampicilina-sulbactam o clindamicina ± ceftriaxona), TAC cervical con contraste.
- Derivar urgente a ORL/cirugía para drenaje; complicaciones: mediastinitis, trombosis yugular (Lemierre) y ruptura carotídea.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un lactante de 2 años presenta fiebre de 39,2 °C, irritabilidad, rechazo alimentario, sialorrea y una postura fija del cuello en extensión con tortícolis dolorosa y estridor inspiratorio leve. En la radiografía lateral de cuello se evidencia un marcado ensanchamiento del espacio de partes blandas prevertebrales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la complicación más temida de no mediar tratamiento urgente?**

A) Absceso retrofaríngeo; mediastinitis necrotizante descendente
B) Croup viral laringotraqueal; estenosis subglótica adquirida
C) Epiglotitis aguda; fístula traqueoesofágica espontánea
D) Absceso periamigdalino bilateral; trombosis de arteria basilar
E) Mononucleosis infecciosa severa; rotura esplénica retardada

Respuesta A. Lactante con tortícolis, estridor y ensanchamiento prevertebral: absceso retrofaríngeo. La complicación más grave es la mediastinitis necrotizante descendente a través del danger space. Requiere hospitalización, TAC con contraste y drenaje quirúrgico.

6.03.2.004 Absceso retrofaríngeo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.14 Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Más frecuente en niños <5 años por supuración de ganglios retrofaríngeos tras infección respiratoria alta.
- Clínica: fiebre, odinofagia, sialorrea, rechazo alimentario, rigidez o tortícolis (no flexiona/extiende el cuello), estridor; abombamiento de pared posterior faríngea.
- Radiografía lateral de cuello: ensanchamiento del espacio prevertebral; confirmar con TAC cervical con contraste.
- Manejo inicial: asegurar vía aérea, hospitalizar, antibiótico EV (ampicilina-sulbactam o clindamicina), hidratación.
- Derivar a ORL para drenaje si hay colección significativa; riesgo de mediastinitis y obstrucción de vía aérea.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 92

Un paciente de 18 años consulta por odinofagia intensa de 2 días asociada a fiebre hasta 38,5 °C y aumento de volumen doloroso submandibular derecho. Tiene faringe congestiva con amígdala derecha aumentada y exudado purulento. Se palpa una masa blanda y dolorosa, con eritema, de 4 cm en la zona submandibular derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Absceso periamigdalino
B) Mononucleosis infecciosa
C) Quiste branquial infectado
D) Adenitis supurada
E) Linfoma de Hodgkin

Respuesta D. Es una amigdalitis bacteriana complicada con una adenitis supurada submandibular. El absceso periamigdalino se caracteriza por dolor muy intenso, trismus y abombamiento del pilar amigdalino, que aquí no aparecen.

6.03.2.005 Atresia coanal congénita

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.15 Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Bilateral: urgencia neonatal; el recién nacido es respirador nasal obligado: cianosis que mejora con el llanto y empeora al alimentarse.
- Diagnóstico: imposibilidad de pasar sonda nasogástrica por ambas fosas (>3 cm); confirmar con nasofibroscopía y TAC.
- Manejo inicial: cánula orofaríngea (Guedel) o chupete de McGovern; intubación si es necesario.
- Asociación con síndrome CHARGE (coloboma, cardiopatía, atresia coanal, retraso, genitales, oído): buscar otras malformaciones.
- Unilateral: rinorrea unilateral persistente en niño mayor. Derivar a ORL para corrección quirúrgica.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Recién nacido de término presenta episodios de cianosis y dificultad respiratoria que empeoran al alimentarse y mejoran con el llanto. Al intentar pasar una sonda nasogástrica por ambas fosas nasales, esta no progresa más allá de 3 cm. **¿Cuál es el diagnóstico y la medida inmediata?**

A) Laringomalacia; posición prona
B) Taquipnea transitoria; oxígeno
C) Hernia diafragmática; intubación y sonda
D) Fístula traqueoesofágica; régimen cero
E) Atresia de coanas bilateral; asegurar vía aérea oral (cánula de Guedel o chupete de McGovern) y derivar para TAC y cirugía

Respuesta E. El recién nacido es respirador nasal obligado: la atresia de coanas bilateral da cianosis cíclica que mejora con el llanto (respira por la boca) y empeora al alimentarse. Se sospecha si la sonda no pasa por las fosas nasales. Se asegura una vía aérea oral, se confirma con TAC y se corrige quirúrgicamente. Se asocia a CHARGE.

6.03.2.006 Barotrauma ótico y trauma acústico agudo

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.6 Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Barotrauma: dolor ótico e hipoacusia tras vuelo o buceo con disfunción tubaria; tímpano retraído, hemotímpano o perforación.
- Trauma acústico agudo: exposición a ruido intenso (explosión, disparo); hipoacusia sensorioneural con escotoma en 4 kHz y tinnitus.
- Manejo inicial barotrauma: analgesia, descongestionantes, maniobra de Valsalva; evitar volar o bucear hasta resolución.
- Trauma acústico agudo: corticoides orales precoces (prednisona 1 mg/kg/día) y audiometría.
- Derivar a ORL: vértigo o hipoacusia sensorioneural sugieren fístula perilinfática (urgencia); perforación que no cierra.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 90

Una paciente de 33 años consulta por otalgia y sensación de oído tapado, mayor a derecha. Refiere que el día anterior estuvo nadando, sumergiéndose a 1,5 metros de profundidad. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Otitis media aguda
B) Otitis media con efusión
C) Perforación timpánica
D) Otitis externa
E) Barotrauma

Respuesta E. Otalgia y oído tapado justo después de un cambio brusco de presión, como el buceo, un vuelo o un cambio de altitud, es un barotrauma ótico. Se maneja con analgesia, descongestionantes y evitando nuevos cambios de presión hasta que se resuelva.

Pregunta de práctica

Un paciente de 72 años consulta porque desde hace 3 años presenta dificultad para entender las conversaciones cuando asiste a reuniones familiares o en lugares con ruido de fondo, refiriendo que "oye pero no entiende". No tiene otalgia ni vértigo. La audiometría demuestra una hipoacusia sensorioneural bilateral y simétrica, con mayor caída en los tonos agudos (3000 a 8000 Hz) y caída de la discriminación de la palabra al 60%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el beneficio en el sistema de salud chileno?**

A) Otoesclerosis bilateral; resolución quirúrgica con estapedectomía GES
B) Presbiacusia; patología con Garantía Explícita en Salud (GES) con indicación de audífonos bilaterales
C) Enfermedad de Ménière bilateral; tratamiento con restricción de sal y acetazolamida
D) Trauma acústico crónico; derivación a mutualidad de seguridad laboral para indemnización
E) Neurinoma del acústico bilateral; estudio genético urgente para Neurofibromatosis tipo 1

Respuesta B. Es presbiacusia: hipoacusia sensorioneural bilateral, simétrica, en agudos, con mala discriminación en ambientes ruidosos. En Chile, la hipoacusia en personas de 65 años y más tiene GES, con confirmación diagnóstica, audífonos y rehabilitación.

6.03.2.007 Cuerpo extraño en el oído

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.18 Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- Más frecuente en niños; objetos inertes (semillas, piedras, juguetes) o insectos vivos; puede presentarse con otalgia, otorrea o hipoacusia.
- Pilas de botón: urgencia, extracción inmediata por necrosis tisular; no irrigar.
- Insecto vivo: inmovilizar primero con aceite mineral o lidocaína, luego extraer.
- No irrigar materiales orgánicos (semillas se hinchan) ni si hay perforación timpánica; no intentar extracción sin visión ni instrumental adecuado.
- Derivar a ORL si es esférico, impactado, hay perforación, falla un intento o el niño no coopera (puede requerir anestesia).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 5 años se introdujo un poroto en el oído derecho hace 1 día. Coopera con el examen. A la otoscopía se observa un cuerpo extraño redondo y liso que ocupa el conducto auditivo externo, sin visualizar el tímpano. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Extracción en seco con gancho romo o microaspiración bajo visión directa, derivando a otorrinolaringología si falla
B) Lavado ótico con agua tibia
C) Gotas de agua oxigenada para disolverlo
D) Extracción con pinza cocodrilo
E) Esperar su expulsión espontánea

Respuesta A. Semillas y legumbres absorben agua y se hinchan, así que el lavado está prohibido. Se extraen en seco, con gancho romo pasado por detrás del objeto o con microaspirador, bajo visión. La pinza resbala sobre un objeto redondo y lo empuja hacia el tímpano. Si el niño no coopera o falla el intento, se deriva para extracción bajo microscopio.

6.03.2.008 Cuerpo extraño en el esófago

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Cuerpo Extraño Digestivo · Tema 14.18 Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- Niños: monedas (en esófago se ven de frente en radiografía AP; en tráquea de perfil), pilas, imanes. Adultos: bolo alimentario (carne) sobre estenosis o anillo.
- Clínica: disfagia, odinofagia, sialorrea, incapacidad para tragar saliva, dolor retroesternal; puede ser asintomático.
- Radiografía de cuello y tórax AP y lateral; objetos no radiopacos pueden requerir TAC.
- Pila de botón esofágica, objeto punzante o impactación con sialorrea: endoscopía urgente (<2 horas en pilas). No inducir vómito.
- Derivar para extracción endoscópica; signos de perforación (enfisema subcutáneo, fiebre, dolor) obligan a cirugía urgente.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Un niño de 2 años es traído a urgencia porque hace 1 hora se tragó una pila de botón del control remoto. Presenta sialorrea y rechaza los líquidos, sin dificultad respiratoria. La radiografía muestra una imagen redonda radiopaca con doble contorno en el tercio superior del esófago. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Esperar 24 horas a que pase al estómago y controlar con radiografía
B) Dar una bebida carbonatada para empujarla al estómago
C) Inducir el vómito
D) Indicar laxantes y revisar las deposiciones
E) Endoscopía digestiva alta de urgencia para extraer la pila de inmediato

Respuesta E. Una pila de botón en el esófago es una emergencia: la corriente eléctrica produce necrosis por licuefacción en unas 2 horas, con riesgo de perforación y de fístula traqueoesofágica o aortoesofágica. Se extrae por endoscopía urgente. El doble contorno la distingue de una moneda. Inducir el vómito está contraindicado.

Pregunta de práctica

Niño de 2 años llevado a urgencias porque hace 1 hora tragó una pila de botón del control remoto. Está asintomático. La radiografía de tórax muestra la pila en el esófago medio, con signo del "doble halo". **¿Cuál es la conducta?**

A) Observar y repetir la radiografía en 24 horas
B) Extracción endoscópica inmediata
C) Observar con radiografía cada 1–2 semanas
D) Administrar un laxante
E) Endoscopía electiva solo si aparecen síntomas

Respuesta B. Pila de botón en el esófago: emergencia. La corriente genera una quemadura de la pared en horas, con riesgo de perforación, fístula traqueoesofágica y mediastinitis. Extracción endoscópica inmediata, aunque el niño esté asintomático.

6.03.2.009 Cuerpo extraño en vía aérea

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.18 Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- Más frecuente en niños de 1-3 años (maní, frutos secos); episodio de atoro presenciado con tos súbita, luego sibilancias unilaterales o hipoventilación.
- Obstrucción completa: maniobra de Heimlich (>1 año) o golpes en espalda y compresiones torácicas (lactante); no barrer a ciegas.
- Radiografía de tórax inspiración-espiración: atrapamiento aéreo unilateral; puede ser normal (objetos radiolúcidos).
- Neumonía recurrente o persistente en el mismo lóbulo: sospechar cuerpo extraño retenido.
- Derivar para broncoscopía rígida ante la sola sospecha clínica, incluso con radiografía normal.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 3 años, mientras comía maní, presentó tos asfíctica súbita con cianosis que cedió en pocos minutos. Ahora tiene tos ocasional, está eupneico y saturando 96%. Al examen hay murmullo pulmonar disminuido y sibilancias localizadas en la base derecha. La radiografía en inspiración y espiración muestra atrapamiento aéreo en el pulmón derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Salbutamol inhalado y alta con control
B) Broncoscopía rígida urgente en pabellón, bajo anestesia general
C) Fibrobroncoscopía flexible ambulatoria en 2 semanas
D) Kinesioterapia respiratoria con drenaje postural
E) Amoxicilina oral y control en 7 días

Respuesta B. Un síndrome de penetración seguido de signos focales (hipoventilación y sibilancias unilaterales) y atrapamiento aéreo es aspiración de cuerpo extraño hasta demostrar lo contrario, incluso con radiografía normal. La conducta es la broncoscopía rígida urgente, diagnóstica y terapéutica. La kinesioterapia puede movilizar el cuerpo extraño y obstruir la vía aérea.

6.03.2.010 Cuerpo extraño nasal

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.18 Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- Niño preescolar con rinorrea unilateral purulenta y fétida: cuerpo extraño nasal hasta demostrar lo contrario.
- Pila de botón o imanes: urgencia por necrosis y perforación septal en pocas horas; extracción inmediata.
- Manejo inicial: vasoconstrictor tópico, técnica de presión positiva ("beso de la madre") o soplar con la fosa contralateral ocluida.
- Extraer con pinza o gancho solo con buena visión y cooperación; evitar empujar hacia la rinofaringe (riesgo de aspiración).
- Derivar a ORL si falla el primer intento, el objeto es posterior, impactado o el niño no coopera.

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 14.18

Una madre acude al servicio de urgencia con su hijo de 3 años refiriendo que el niño se introdujo en la fosa nasal izquierda una pila de botón extraída de un juguete hace aproximadamente una hora. El niño presenta llanto y sangrado nasal escaso. Al examen se confirma la presencia de la batería en la fosa nasal. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada?

A) Realizar lavado profuso de la fosa nasal con solución salina para neutralizar el pH y expulsar la pila.
B) Extracción inmediata del cuerpo extraño con gancho romo o derivación urgente a pabellón quirúrgico, sin realizar ninguna irrigación líquida.
C) Indicar descongestionantes orales y citar al policlínico de otorrinolaringología en 48 horas.
D) Instilar gotas de vaselina líquida para facilitar que la pila deslice hacia la nasofaringe.
E) Realizar compresión digital bimanual externa sobre el dorso nasal para aplastar la batería.

Respuesta B. La opción correcta es la B. La pila de botón en una cavidad mucosa como la fosa nasal o el CAE es una emergencia quirúrgica de máxima prioridad debido a la rápida producción de quemaduras químicas alcalinas graves por electrólisis y fuga de hidróxido de potasio, las cuales pueden ocasionar perforación del cartílago septal en menos de 2 horas. La extracción debe realizarse de forma inmediata por personal entrenado con instrumental específico (gancho romo introducido por detrás del objeto). Está estrictamente contraindicada la irrigación con agua o suero (opción A) porque los líquidos actúan como electrolito conductor que acelera catastróficamente la corriente eléctrica y la destrucción tisular.

6.03.2.011 Epistaxis masiva

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.11 Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Epistaxis masiva o posterior: más frecuente en adulto mayor hipertenso o anticoagulado; sangrado por ambas fosas y hacia faringe, arteria esfenopalatina.
- ABC primero: proteger vía aérea, dos vías venosas, hemograma, grupo y Rh, pruebas de coagulación; reposición de volumen.
- Taponamiento anterior; si sigue sangrando a la faringe, taponamiento posterior (sonda Foley o balón) más anterior; hospitalizar con antibiótico profiláctico.
- Controlar presión arterial y revertir anticoagulación según indicación; taponamiento posterior se retira a las 48-72 horas.
- Derivar a ORL para ligadura/cauterización endoscópica de esfenopalatina o embolización si falla el taponamiento.

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 14.11

Una paciente de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial presenta epistaxis masiva que no ha cedido tras taponamiento anterior bilateral con Merocel, evidenciándose sangrado activo continuo y abundante por la faringe posterior. Se decide realizar taponamiento nasal posterior con sonda Foley. Respecto al manejo integral de esta paciente, ¿cuál de las siguientes medidas es una indicación OBLIGATORIA?

A) Alta inmediata a domicilio con indicación de retirar la sonda Foley a las 12 horas.
B) Hospitalización con monitorización de signos vitales e inicio de antibióticos profilácticos sistémicos.
C) Insuflar el balón de la sonda Foley con 25 mL de aire para asegurar hemostasia máxima.
D) Suspensión absoluta de toda hidratación parenteral y mantener presión arterial sistólica sobre 180 mmHg.
E) Realizar cauterización a ciegas con nitrato de plata de la pared posterior de la orofaringe.

Respuesta B. La opción correcta es la B. La epistaxis posterior que requiere taponamiento con balón o sonda Foley es una situación clínica grave que exige HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA del paciente por riesgo de hipoxia, bradiarritmias por reflejo nasovagal y aspiración. Además, la presencia de taponamiento posterior ocluye el ostium de drenaje de los senos paranasales y favorece la proliferación bacteriana en tejidos retenidos, lo que hace mandatorio el inicio de profilaxis antibiótica sistémica (habitualmente amoxicilina con ácido clavulánico o cefazolina) para prevenir el temible Síndrome de Shock Tóxico estafilocócico y la rinosinusitis aguda supurada. El balón se insufla con agua (nunca aire, que se desinfla por difusión) y solo con 8-10 mL para evitar necrosis tisular.

6.03.2.012 Fractura nasal reciente

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.12 Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

QUÉ HAY QUE SABER

- Traumatismo nasal con epistaxis, dolor, edema, deformidad o crepitación; el diagnóstico es clínico, la radiografía es poco útil.
- Siempre descartar hematoma septal (abombamiento violáceo del tabique) y lesiones asociadas: fractura orbitaria, nasoetmoidal, fístula de LCR.
- Manejo inicial: control de epistaxis, hielo, analgesia, antibiótico si hay herida abierta.
- Reducción cerrada idealmente en los primeros 7-10 días (antes de consolidar) o inmediata si no hay edema importante.
- Derivar a ORL en 3-5 días para reevaluar deformidad una vez disminuido el edema.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 22 años recibió un puñetazo en la nariz hace 2 horas. Tuvo epistaxis que ya cedió. Al examen hay edema y dolor del dorso nasal, laterorrinia hacia la izquierda y crepitación ósea. En la rinoscopía anterior el tabique no está abombado, la mucosa es normal y no hay hematoma septal. Respira bien por ambas fosas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Radiografía de huesos propios para decidir la cirugía
B) Reducción abierta urgente hoy en pabellón
C) Esperar 3 meses y realizar rinoseptoplastia
D) Drenaje del tabique nasal
E) Frío local, analgesia y reevaluación por otorrinolaringología a los 5 a 7 días, para reducción cerrada si persiste la deformidad

Respuesta E. En la fractura nasal lo urgente es descartar un hematoma septal, ya hecho. Si no hay hematoma, se indica frío y analgesia, y se reevalúa cuando baja el edema, a los 5 a 7 días, para reducción cerrada antes de las 2 semanas. El diagnóstico es clínico; la radiografía solo tiene valor médico-legal.

6.03.2.013 Hematoma nasoseptal

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.12 Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

QUÉ HAY QUE SABER

- Colección de sangre bajo el pericondrio septal tras trauma nasal: obstrucción nasal bilateral y abombamiento violáceo y blando del tabique.
- Urgencia: riesgo de necrosis del cartílago en 24-72 horas, absceso septal y nariz en silla de montar.

- Tratamiento: drenaje urgente (incisión o punción), taponamiento anterior bilateral para evitar recolección y antibiótico antiestafilocócico.
- En niños con trauma nasal siempre examinar el tabique con rinoscopía.
- Derivar a ORL para drenaje y control; absceso septal puede dar trombosis del seno cavernoso.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 171

Un paciente de 34 años, sin antecedentes, sufre caída mientras subía una escalera, resultando con golpe en su rostro, al ingreso se en buenas condiciones generales, pero con epistaxis. Se realiza especuloscopía nasal donde se aprecia engrosamiento septal bilateral y epistaxis anterior. **La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Drenaje por punción
B) Observar y controlar en 2 semanas
C) Drenaje quirúrgico urgente
D) Antibióticos endovenosos
E) Taponamiento nasal bilateral

Respuesta C. El engrosamiento septal bilateral tras un golpe es un hematoma del tabique. Requiere drenaje quirúrgico urgente, seguido de taponamiento y antibiótico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 168

Un paciente de 28 años presenta un pelotazo en la cara, hace 5 días, con golpe en la nariz. Evoluciona con dolor, edema, obstrucción nasal y luego sensación febril. Al examen físico se observa aumento de volumen bilateral, en relación al tabique nasal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Drenaje por punción con aguja fina
B) Drenaje quirúrgico con bisturí
C) Taponamiento anterior
D) Administrar analgésicos
E) Reducción en pabellón

Respuesta B. Un hematoma septal que lleva días y ya produce fiebre se ha sobreinfectado: es un absceso septal. Se drena con bisturí; la punción con aguja no basta.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 101 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 18 años sufre un pelotazo en la cara hace 7 días, evolucionando con dolor, obstrucción nasal, rinorrea purulenta y fiebre. Está subfebril y se aprecia aumento de volumen bilateral, en relación al septo nasal. En sus exámenes destaca leucocitosis de 15.000 blancos por mm3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar drenaje con punción
B) Indicar antibióticos orales
C) Poner tapón, con gasas empapadas en antibióticos tópicos
D) Indicar corticoides y descongestionantes
E) Realizar drenaje inmediato con bisturí

Respuesta E. Es un hematoma septal bilateral. Debe drenarse en pabellón, de manera urgente, para evitar la necrosis del cartílago septal.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 118 · texto original del banco, sin revisar

Adolescente con antecedente de trauma nasal hace 5-7 días, que consulta por fiebre y obstrucción nasal bilateral:

A) Hematoma septal
B) Absceso septal (confirmado por un ORL, Guevara se equivocó (también se equivoca guevara no olvidar))
C) Staphylococcus aureus
D) Streptococcus pneumoniae
E) Escherichia coli

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Absceso septal (confirmado por un ORL, Guevara se equivocó (también se equivoca guevara no olvidar))). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

6.03.2.014 Otohematoma

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.3 Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Colección de sangre entre pericondrio y cartílago del pabellón tras trauma (deportes de contacto); aumento de volumen fluctuante y violáceo.
- Riesgo: necrosis del cartílago y fibrosis ("oreja en coliflor") o pericondritis si no se drena.
- Tratamiento: drenaje precoz por punción o incisión en condiciones estériles, más vendaje compresivo para evitar recolección.
- Antibiótico profiláctico con cobertura de Pseudomonas y estafilococo (ciprofloxacino) y control en 24-48 horas.
- Derivar a ORL si es recurrente, extenso, de más de 7 días o con signos de pericondritis.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 22 años, practicante de lucha libre, consulta por aumento de volumen fluctuante, violáceo y doloroso en la cara anterior del pabellón auricular derecho, tras un golpe hace 24 horas. Borra los relieves del pabellón. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Drenaje del hematoma (punción o incisión) y vendaje compresivo, para evitar la deformidad en "oreja en coliflor"
> **B)** Hielo y control en 1 semana
> **C)** Antibiótico oral solamente
> **D)** Esperar reabsorción espontánea
> **E)** Cirugía reconstructiva electiva en 6 meses
>
> Respuesta A. El otohematoma es la colección de sangre entre el pericondrio y el cartílago auricular tras un trauma. Como el cartílago se nutre del pericondrio, si no se drena precozmente se produce necrosis, infección (pericondritis) y fibrosis con deformidad permanente (oreja en coliflor). Se drena y se aplica compresión para evitar la recolección, con control y antibiótico según el caso.

6.03.2.015 Otorragia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- Sangrado por el conducto auditivo; causas: trauma del conducto (cotonito), perforación timpánica, otitis externa, OMA perforada o fractura de base de cráneo.
- Post-TEC: fractura del temporal; buscar otolicuorrea, signo de Battle, parálisis facial, hipoacusia y vértigo.
- Manejo inicial: no lavar ni introducir gotas, oído seco; otoscopía cuidadosa, analgesia.
- En TEC: evaluación neuroquirúrgica y TAC de cerebro y peñasco.
- Derivar a ORL ante perforación, parálisis facial, hipoacusia sensorioneural, vértigo o salida de LCR.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 30 años sufre un TEC por caída de altura. Glasgow 14. Presenta otorragia derecha, equimosis retroauricular derecha (signo de Battle) e hipoacusia derecha. La otoscopía muestra sangre en el conducto auditivo externo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Lavado de oído para visualizar el tímpano
> **B)** Taponamiento compacto del conducto auditivo
> **C)** Gotas óticas de ciprofloxacino y alta
> **D)** No manipular ni lavar el oído; TAC de cerebro y de hueso temporal por sospecha de fractura de base de cráneo y evaluación de parálisis facial
> **E)** Aspirar el conducto en el servicio de urgencia
>
> Respuesta D. La otorragia postraumática con signo de Battle sugiere fractura del hueso temporal (base de cráneo media), que puede asociarse a fístula de LCR, lesión del oído medio o interno y parálisis facial. No se debe lavar ni taponar el oído (riesgo de meningitis). Se estudia con TAC de cerebro y de peñasco, se evalúa el nervio facial y la audición.

6.03.2.016 Perforación timpánica traumática

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.6 Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Causas: golpe con mano abierta, cotonitos, barotrauma, explosión; otalgia súbita, otorragia escasa e hipoacusia de conducción.
- Manejo: mantener oído seco, no lavar ni usar gotas ototóxicas; analgesia. Antibiótico oral solo si hay infección o contaminación.
- La mayoría cierra espontáneamente en 4-8 semanas; control otoscópico y audiometría.
- Banderas rojas: vértigo, nistagmo, hipoacusia sensorioneural o parálisis facial: lesión de oído interno o fístula perilinfática, derivación urgente.
- Derivar a ORL si no cierra en 3 meses (timpanoplastía) o hay complicaciones.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 138

Paciente usuaria habitual de cotonito (hisopo) consulta por otalgia e hipoacusia leve tras su uso. En la otoscopía se observa una perforación timpánica traumática. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Control en 1 mes (resolución espontánea)
B) Tapón de algodón y antibiótico tópico ótico
C) Miringoplastía inmediata
D) TAC de hueso temporal
E) Derivar a ORL urgente

Respuesta A. La mayoría de las perforaciones timpánicas traumáticas pequeñas cierran espontáneamente en semanas. Se indica mantener el oído seco (no mojar, no lavar, no usar gotas salvo infección), analgesia, y control otoscópico y audiométrico. Se deriva con urgencia si hay vértigo, hipoacusia sensorioneural, parálisis facial u otorrea; si no cierra en 2 a 3 meses, timpanoplastía.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 44 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 32 años, consulta por dolor intenso en el oído izquierdo, que inició después de haberse limpiado con un cotonito (hisopo). No tiene síntomas vestibulares, aunque refiere hipoacusia moderada en dicho oído. Se realiza otoscopía, que muestra presencia de una perforación timpática triangular, con sangre en el conducto auditivo externo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Lavado de oídos
B) Ciprofloxacino tópico
C) Derivar a timpanoplastía
D) Control en un mes
E) TAC de oídos

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Lavado de oídos (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Ciprofloxacino tópico, Derivar a timpanoplastía) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la pr

6.03.2.017 Síndrome vertiginoso agudo

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.20 Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS · Tema 14.7 Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome vestibular agudo: vértigo continuo con náuseas, vómitos y nistagmo; la principal decisión es distinguir periférico (neuronitis) de central (ACV de fosa posterior).
- HINTS: impulso cefálico alterado, nistagmo unidireccional horizontal y skew negativo sugieren periférico; impulso normal, nistagmo cambiante o skew positivo sugieren central.
- Banderas rojas: déficit neurológico, cefalea súbita, ataxia severa (no puede caminar), factores de riesgo vascular, hipoacusia súbita: imagen y neurología urgente.
- Neuronitis vestibular: sedante vestibular (dimenhidrinato) por máximo 2-3 días, corticoide (prednisona 1 mg/kg/día) e hidratación; movilización precoz.
- Derivar a ORL para estudio vestibular y rehabilitación; VPPB se trata con maniobras de reposición.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 88

Una paciente de 43 años presenta vértigo de 5 días de evolución, intenso, asociado a vómitos, lo que limita sus actividades. No tiene síntomas auditivos. **El diagnóstico más probable es:**

A) Parálisis cocleovestibular
B) Vértigo postural
C) Hídrops endolinfático
D) Neuronitis vestibular
E) Neurinoma del acústico

Respuesta D. Vértigo intenso y continuo de días, con vómitos y sin síntomas auditivos: neuronitis vestibular. La ausencia de síntomas auditivos descarta la parálisis cocleovestibular y el hídrops endolinfático (Menière); el vértigo postural dura segundos.

6.03.2.018 Sordera súbita

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.6 Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipoacusia sensorioneural ≥30 dB en 3 frecuencias contiguas instalada en <72 horas, generalmente unilateral, con tinnitus o plenitud.
- Diferenciar de tapón de cerumen u OME con otoscopía y diapasones (Weber lateraliza al sano, Rinne positivo).
- Tratamiento urgente: prednisona 1 mg/kg/día (máx. 60 mg) por 7-14 días, iniciar idealmente en las primeras 72 horas.
- Solicitar audiometría urgente (24-48 horas) y RM para descartar neurinoma del acústico.
- Derivar a ORL de forma urgente; corticoide intratimpánico como rescate.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 123

Paciente de 45 años con pérdida súbita de audición unilateral de 48 horas de evolución, sin vértigo ni acúfenos. Audiometría: hipoacusia neurosensorial unilateral de 50 dB. **¿Cuál es el tratamiento?**

A) Corticoides orales (prednisona 1 mg/kg/día x 10 días)
B) Antibióticos orales
C) Antivirales (aciclovir)
D) Solo observar, resolución espontánea
E) Cirugía descompresiva del nervio auditivo

Respuesta A. Hipoacusia súbita neurosensorial: el tratamiento estándar son corticoides orales en dosis alta, prednisona 1 mg/kg/día, iniciados dentro de las primeras 72 horas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 110

Un hombre de 33 años, sin antecedentes de importancia, despierta con hipoacusia del oído izquierdo, asociado a tinitus, sin otros síntomas. No ha presentado vértigo y su otoscopía no muestra alteraciones. Su examen neurológico no aporta nueva información. **¿Cuál es el examen inicial para evaluar a este paciente?**

A) Impedanciometría
B) TAC de oído
C) TAC de cerebro
D) Prueba calórica
E) Audiometría

Respuesta E. Hipoacusia brusca con tinnitus y otoscopía normal: el examen inicial es la audiometría, que confirma la pérdida sensorioneural y orienta el tratamiento urgente.

Conocimientos generales 7 códigos

6.03.3.001 Detección de hipoacusia y sordera en niños

Dónde se enseña: Tema 18.21 Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje auditivo neonatal universal con emisiones otoacústicas antes del alta; en riesgo (UCI >5 días, prematuros) usar PEAT automatizado.
- Estrategia 1-3-6: tamizaje antes del mes, diagnóstico confirmado antes de los 3 meses e intervención antes de los 6 meses.
- GES: hipoacusia bilateral del prematuro (<32 semanas o <1.500 g) e hipoacusia moderada o mayor en menores de 4 años con audífonos.
- Pesquisa en control sano: preguntar si reacciona al ruido, balbuceo, desarrollo del lenguaje; cualquier sospecha parental justifica estudio.
- Seguimiento audiológico en factores de riesgo de hipoacusia tardía (CMV, meningitis, ototóxicos) aunque el tamizaje haya sido normal.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Recién nacido de término sano, con tamizaje auditivo universal con emisiones otoacústicas que resultó "refiere" en el oído derecho en 2 ocasiones antes del alta. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Repetir las emisiones a los 2 años
> **B)** Tranquilizar, porque la hipoacusia unilateral no tiene importancia
> **C)** Confirmar con potenciales evocados auditivos de tronco cerebral antes de los 3 meses, para iniciar intervención antes de los 6 meses
> **D)** Esperar a que el niño comience a hablar
> **E)** Solicitar TAC de oídos inmediatamente
>
> Respuesta C. El tamizaje auditivo neonatal universal (GES hipoacusia del prematuro y programa nacional) busca la meta 1-3-6: tamizaje antes del mes, confirmación diagnóstica con potenciales evocados auditivos antes de los 3 meses e intervención (audífonos, implante) antes de los 6 meses, para preservar el desarrollo del lenguaje. Un tamizaje alterado nunca debe esperar.

6.03.3.002 Pesquisa de trastornos del lenguaje

Dónde se enseña: Tema 18.2 Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Pesquisa en control de salud infantil con tests de desarrollo psicomotor (EEDP hasta 2 años, TEPSI 2-5 años) y pauta de lenguaje.
- Alerta: no balbucea a los 9-12 meses, sin palabras a los 16-18 meses, sin frases de 2 palabras a los 24 meses, pérdida de lenguaje adquirido.
- Ante retraso: descartar hipoacusia (audiometría/PEAT) y trastorno del espectro autista (M-CHAT).
- Estimulación: lectura diaria, conversación, limitar pantallas en menores de 2 años; programa Chile Crece Contigo.
- Derivar a fonoaudiología y neurología infantil según hallazgos; intervención precoz mejora el pronóstico.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> En el control sano de los 18 meses se evalúa el lenguaje de un niño. Su madre dice que no dice ninguna palabra con significado, aunque balbucea. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**
>
> **A)** Normal; a los 18 meses aún no se espera ninguna palabra
> **B)** Señal de alerta: a los 18 meses se esperan al menos varias palabras con significado; requiere evaluación auditiva, del desarrollo (incluida pesquisa de autismo) y derivación a fonoaudiología
> **C)** Normal si es varón
> **D)** Esperar hasta los 3 años para evaluar
> **E)** Indicar que la madre le hable en un solo idioma y controlar a los 4 años
>
> Respuesta B. Son señales de alerta: no balbucear a los 12 meses, no decir palabras a los 16 a 18 meses, no combinar 2 palabras a los 24 meses o cualquier pérdida de lenguaje. Ante ellas se descarta hipoacusia, se pesquisa trastorno del espectro autista (M-CHAT) y se deriva a fonoaudiología. En Chile se pesquisa con EEDP y TEPSI.

6.03.3.003 Prevención de alergias nasosinusales

Dónde se enseña: Tema 14.9 Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

QUÉ HAY QUE SABER

- Control ambiental: fundas antiácaros, lavado de ropa de cama a ≥60 °C, retirar alfombras y peluches, ventilar y reducir humedad.
- Evitar humo de tabaco y contaminación intradomiciliaria (estufas a leña); mascotas fuera del dormitorio si hay sensibilización.
- Polinosis: cerrar ventanas en temporada alta (primavera), lentes, ducha al llegar a casa; iniciar corticoide intranasal antes de la temporada.
- Lactancia materna exclusiva y no retrasar la introducción de alimentos se asocian a menor atopia.
- Inmunoterapia específica (por especialista) modifica la historia natural y reduce progresión a asma en pacientes seleccionados.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 10 años con rinitis alérgica persistente moderada, con pruebas cutáneas positivas solo para ácaros del polvo doméstico (Dermatophagoides). **¿Cuál de las siguientes medidas de control ambiental es más adecuada?**

A) Mantener alfombras y peluches en el dormitorio
B) Uso de antibióticos profilácticos en invierno
C) Evitar el consumo de leche
D) Mantener la casa cerrada y sin ventilar
E) Usar fundas antiácaros en colchón y almohada, lavar ropa de cama semanalmente con agua caliente, reducir alfombras y peluches y mantener baja la humedad del dormitorio

Respuesta E. La prevención en rinitis alérgica se basa en identificar y evitar el alérgeno. Para ácaros se recomiendan fundas antiácaros, lavado de ropa de cama con agua caliente, retirar alfombras, cortinas gruesas y peluches del dormitorio, ventilar y reducir la humedad, además de evitar el humo de tabaco. Se combina con corticoide intranasal e inmunoterapia en casos seleccionados.

6.03.3.004 Prevención de cáncer laríngeo

Dónde se enseña: Tema 14.20 Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Principal medida: cesación tabáquica; tabaco y alcohol tienen efecto sinérgico en el riesgo de cáncer laríngeo.
- Otros factores: exposición ocupacional (asbesto, níquel, hidrocarburos), reflujo laringofaríngeo, VPH.
- Detección precoz: toda disfonía de más de 3 semanas, sobre todo en fumador mayor de 40 años, requiere laringoscopía.
- Lesiones premalignas (leucoplasia, displasia de cuerda vocal) requieren biopsia y seguimiento por ORL.
- Consejería breve antitabaco en cada atención (modelo 5A) y apoyo farmacológico (vareniclina, bupropión, TRN).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 50 años, fumador de 30 paquetes-año y consumidor de alcohol diario, consulta en APS por un control preventivo. No tiene síntomas. **¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir el cáncer de laringe en este paciente?**

A) Nasofibrolaringoscopía anual de tamizaje
B) Antiinflamatorios diarios
C) Vitamina E diaria
D) Cesación tabáquica y reducción del consumo de alcohol
E) Reposo vocal

Respuesta D. El tabaco es el principal factor de riesgo de cáncer de laringe y el alcohol potencia su efecto en forma sinérgica. La prevención primaria es la cesación tabáquica y la reducción del alcohol. No existe tamizaje poblacional recomendado; la clave es la detección precoz de síntomas: toda disfonía de más de 3 semanas en un fumador debe evaluarse con laringoscopía.

6.03.3.005 Prevención de cuerpo extraño en niños

Dónde se enseña: Tema 14.18 Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- No dar frutos secos (maní, nueces), uvas enteras, salchichas en trozos redondos ni dulces duros a menores de 4-5 años.
- Supervisar la alimentación: niño sentado, sin correr, reír ni jugar con comida en la boca.

- Juguetes adecuados a la edad (sin piezas pequeñas); guardar pilas de botón, imanes y monedas fuera del alcance.
- Enseñar a los padres primeros auxilios: golpes en la espalda y compresiones torácicas en lactantes, Heimlich en mayores de 1 año.
- Consejería anticipatoria en control de niño sano desde los 6 meses.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> En el control sano de los 12 meses, la madre pregunta qué alimentos y objetos debe evitar para prevenir la aspiración de cuerpos extraños. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**
>
> **A)** Ofrecer maní y frutos secos enteros desde el año para estimular la masticación
> **B)** Evitar frutos secos enteros, uvas y salchichas enteras, caramelos duros y juguetes con piezas pequeñas hasta al menos los 4 a 5 años, y supervisar siempre la alimentación sentado
> **C)** Permitir que coma mientras corre para que no se distraiga
> **D)** Los juguetes con pilas de botón son seguros si están cerrados con pegamento
> **E)** Solo los globos de látex son peligrosos
>
> Respuesta B. La aspiración de cuerpo extraño es más frecuente entre 1 y 3 años. Se previene evitando frutos secos enteros, semillas, uvas y salchichas enteras (cortarlas en trozos pequeños longitudinalmente), dulces duros, globos y objetos pequeños; con pilas de botón en compartimentos asegurados con tornillo; y comiendo sentado y supervisado, sin correr ni reír con comida en la boca.

6.03.3.006 Prevención de otitis externa

Dónde se enseña: Tema 14.3 Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Evitar cotonitos y manipulación del conducto: eliminan cerumen protector y producen microtrauma.
- Secar bien los oídos tras nadar o ducharse; tapones en nadadores frecuentes; ladear la cabeza para drenar el agua.
- Gotas acidificantes o de alcohol boricado tras el baño en pacientes con otitis externa recurrente (si tímpano íntegro).
- Tratar dermatitis del conducto y controlar glicemia en diabéticos (riesgo de otitis externa maligna).
- Limpieza periódica de audífonos y tapones.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Nadador de 16 años con 3 episodios de otitis externa difusa en el último verano, tratados con gotas antibióticas. Consulta para prevenir nuevos episodios. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**
>
> **A)** Limpiar diariamente el conducto con cotonito después de nadar
> **B)** Secar el pabellón y la entrada del conducto tras nadar (inclinando la cabeza o con secador a baja temperatura), usar tapones y evitar introducir cotonitos u objetos
> **C)** Usar gotas antibióticas profilácticas diarias durante todo el verano
> **D)** Lavarse los oídos con agua a presión semanalmente
> **E)** Antibiótico oral profiláctico
>
> Respuesta B. La otitis externa se favorece por la humedad, la pérdida del cerumen protector y el trauma del conducto (cotonitos, rascado). Se previene manteniendo el conducto seco tras el baño (inclinar la cabeza, secador tibio, gotas acidificantes o alcohol boricado si no hay perforación), usando tapones y evitando la manipulación. Los antibióticos profilácticos favorecen resistencia y otomicosis.

6.03.3.007 Prevención de trauma acústico y daño por exposición a ruidos

Dónde se enseña: Tema 14.6 Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Ruido ocupacional >85 dB por 8 horas produce hipoacusia sensorioneural irreversible; muesca característica en 4 kHz.
- Protocolo PREXOR (MINSAL): vigilancia de trabajadores expuestos a ruido con audiometrías periódicas; enfermedad profesional cubierta por la Ley 16.744.

- Medidas: reducir el ruido en la fuente, limitar tiempo de exposición, protectores auditivos (tapones u orejeras) bien utilizados.
- Ruido recreacional: audífonos a <60% del volumen máximo por <60 minutos (regla 60/60); protección en conciertos y disparos.
- Tinnitus o sensación de oído tapado tras exposición es señal de alarma; ante trauma acústico agudo, audiometría y evaluación precoz.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 30 años ingresa a trabajar a una maestranza donde el ruido medido en su puesto es de 92 dB durante la jornada de 8 horas. Su audiometría de ingreso es normal y no tiene síntomas. **¿Cuál es la medida preventiva más adecuada?**

A) Protectores auditivos durante toda la exposición y audiometrías periódicas de vigilancia
B) Ninguna, hasta que aparezca hipoacusia
C) Corticoides orales profilácticos en los períodos de más ruido
D) Audífonos desde el ingreso
E) Lavados óticos mensuales

Respuesta A. Sobre 85 dB por 8 horas hay riesgo de hipoacusia laboral, cuyo daño no revierte. Se previene reduciendo el ruido en la fuente, usando protectores auditivos durante toda la exposición y vigilando con audiometrías periódicas (protocolo PREXOR del MINSAL), buscando precozmente la muesca en 4000 Hz.

Exámenes e imagenología 11 códigos

6.03.4.001 Radiografía de cavidades perinasales

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 14.10 Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Proyecciones: Waters (occipitomentoniana) para senos maxilares, Caldwell para frontales y etmoides; lateral para esfenoides.
- Signos de sinusitis: nivel hidroaéreo, opacificación completa o engrosamiento mucoso >4-5 mm; pero tiene baja sensibilidad y especificidad.
- No se requiere para el diagnóstico de rinosinusitis aguda, que es clínico; en niños pequeños los senos no están completamente desarrollados.
- Los senos frontales aparecen radiológicamente hacia los 6-8 años; maxilares y etmoidales están presentes desde el nacimiento.
- Ha sido reemplazada por la TAC cuando se sospecha complicación, enfermedad crónica o se planifica cirugía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 30 años con rinorrea purulenta, congestión nasal y dolor facial maxilar de 4 días, tras un resfrío. Afebril, en buen estado general, sin signos orbitarios ni neurológicos. Solicita una radiografía de cavidades perinasales. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a las imágenes?**

A) No solicitar imágenes; el diagnóstico de rinosinusitis aguda es clínico, y las imágenes se reservan para complicaciones, falla de tratamiento o enfermedad crónica
B) Radiografía de cavidades perinasales para confirmar sinusitis
C) TAC de cavidades perinasales urgente
D) Resonancia magnética
E) Radiografía de cavum

Respuesta A. La rinosinusitis aguda es un diagnóstico clínico. La radiografía de cavidades perinasales tiene baja sensibilidad y especificidad (el velamiento también ocurre en resfríos virales) y no cambia el manejo. Si se requiere imagen (complicación orbitaria o intracraneana, cronicidad, planificación quirúrgica), el examen de elección es la TAC.

6.03.4.002 Radiografía de cavum

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 14.15 Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Radiografía lateral de cavum (rinofaringe) para evaluar el tamaño de las adenoides en niños con respiración bucal, ronquido u OME.
- Relación adenoides/nasofaringe (índice de Fujioka): >0,7-0,8 sugiere hipertrofia obstructiva.
- Útil para indicar adenoidectomía junto con la clínica; la nasofibroscopía es el estándar para evaluar la vía aérea.
- En adultos, una masa en cavum obliga a descartar carcinoma nasofaríngeo (efusión unilateral persistente).
- La radiografía lateral de cuello también ayuda en absceso retrofaríngeo (ensanchamiento prevertebral).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 23

Un niño de 5 años presenta infecciones respiratorias a repetición, rinorrea bilateral frecuente y obstrucción nasal con respiración bucal habitual. La madre relata roncopatía y dificultades para dormir. Ha tenido dos episodios recientes de otitis media aguda que respondieron a amoxicilina. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?**

A) Radiografía de cavum
B) TAC de cavidades paranasales
C) Nasofibroscopía
D) Polisomnografía
E) Niveles plasmáticos de IgE específica contra alérgenos respiratorios

Respuesta A. La sospecha es hipertrofia de adenoides. Aunque la nasofibroscopía es el mejor examen y se hará en segunda línea, el inicial es la radiografía de cavum, que es barata y menos molesta para el niño.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 23

Niño de 5 años presenta infecciones respiratorias a repetición, asociadas a rinorrea bilateral frecuente y obstrucción nasal con respiración bucal habitual. La madre relata roncopatía y dificultades para dormir. Recientemente ha presentado 2 episodios de otitis media aguda que respondieron a amoxicilina. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?**

A) Radiografía de cavum
B) TAC de cavidades paranasales
C) Nasofibroscopía
D) Polisomnografía
E) Niveles plasmáticos de IgE específica contra alérgenos respiratorios

Respuesta A. Respiración bucal, ronquido, rinorrea y otitis recurrentes en un preescolar sugieren hipertrofia adenoidea. La radiografía lateral de cavum es un examen simple y accesible para iniciar el estudio, al mostrar la relación adenoides-nasofaringe. La nasofibroscopía la confirma en el nivel especializado y la polisomnografía se reserva para dudas sobre la gravedad del SAHOS.

6.03.4.003 TAC de cavidades perinasales

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 14.10 Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de elección para estudiar cavidades perinasales: rinosinusitis crónica, poliposis y planificación de cirugía endoscópica.
- Indicada en rinosinusitis aguda con sospecha de complicación orbitaria o intracraneal (con contraste) y en fracaso de tratamiento médico.
- Evaluar ocupación sinusal, permeabilidad del complejo osteomeatal, erosión ósea (tumor) y variantes anatómicas.
- Erosión ósea o masa unilateral sugiere tumor; complementar con RM.
- No se solicita en rinosinusitis aguda no complicada.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 7 años con rinosinusitis aguda de 5 días que presenta edema palpebral izquierdo, proptosis, dolor a la movilización ocular y disminución de la agudeza visual. Temperatura 39 °C. **¿Cuál es el examen de imagen de elección?**

A) Radiografía de cavidades perinasales
B) Ecografía ocular
C) TAC de cavidades perinasales y órbitas con contraste
D) Radiografía de cavum
E) No requiere imágenes

Respuesta C. Proptosis, oftalmoplejía dolorosa y disminución visual en un niño con sinusitis indican celulitis orbitaria o absceso subperióstico, complicaciones de la etmoiditis. Requiere TAC de cavidades perinasales y órbitas con contraste urgente para identificar abscesos que necesitan drenaje, antibióticos endovenosos y evaluación por ORL y oftalmología. La TAC es también el examen para sinusitis crónica y planificación quirúrgica.

6.03.4.004 TAC cervical con contraste

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 14.14 Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de elección en infecciones profundas de cuello: diferencia celulitis/flegmón de absceso (colección hipodensa con realce periférico).
- Indicada en sospecha de absceso retrofaríngeo, parafaríngeo, angina de Ludwig o absceso periamigdalino con extensión.
- Evalúa extensión a mediastino, compromiso vascular (trombosis yugular) y de vía aérea.
- En masa cervical del adulto: caracteriza tamaño, necrosis ganglionar y tumor primario para etapificación.
- Precauciones: función renal y alergia al contraste; no retrasar el manejo de la vía aérea por el examen.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 35 años con odontalgia molar inferior hace 1 semana, ahora con fiebre de 39 °C, trismus, aumento de volumen submandibular y cervical lateral izquierdo doloroso y odinofagia. Sin estridor ni dificultad respiratoria. **¿Cuál es el examen de elección para evaluar este cuadro?**

A) Radiografía de cuello lateral
B) Ecografía Doppler carotídea
C) TAC de cuello con contraste endovenoso
D) Resonancia magnética sin contraste
E) Panorámica dental exclusivamente

Respuesta C. La sospecha de infección profunda del cuello (absceso parafaríngeo, submandibular, angina de Ludwig) requiere TAC cervical con contraste: distingue celulitis de absceso, muestra su extensión (mediastino) y su relación con la vía aérea y los vasos. Se acompaña de antibióticos endovenosos y drenaje si hay colección. Antes, siempre asegurar la vía aérea.

6.03.4.005 TAC de oídos sin medio de contraste

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 14.2 Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de elección para estudiar hueso temporal: otitis media crónica, colesteatoma, malformaciones y fracturas del peñasco.
- Colesteatoma: masa de partes blandas con erosión ósea (escudo, huesecillos, conducto semicircular lateral, tegmen).
- En fractura de temporal post-TEC evalúa trazo longitudinal (hipoacusia conductiva) vs transverso (sensorioneural y parálisis facial).
- Para complicaciones intracraneales o absceso se requiere contraste o RM.
- Para sospecha de neurinoma del acústico el examen indicado es RM con gadolinio, no TAC.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 40 años con otorrea fétida crónica del oído derecho e hipoacusia progresiva. La otoscopía muestra una perforación timpánica marginal posterosuperior con material blanquecino descamativo. Se planifica cirugía. **¿Cuál es el examen de imagen de elección para evaluar la extensión de la lesión?**

A) Audiometría solamente
B) Radiografía de Schüller
C) Resonancia magnética de cerebro con contraste como primer examen
D) Ecografía de mastoides
E) TAC de oídos (hueso temporal) sin medio de contraste

Respuesta E. Una perforación marginal o atical con escamas blanquecinas y otorrea fétida es un colesteatoma. La TAC de hueso temporal sin contraste, de alta resolución, es el examen de elección para evaluar la erosión ósea (cadena osicular, canal semicircular lateral, tegmen, canal del facial) y planificar la cirugía. La resonancia se usa ante sospecha de complicación intracraneana o recidiva.

6.03.4.006 Audiometría básica

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 14.5 Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

QUÉ HAY QUE SABER

- Mide umbrales auditivos por vía aérea y ósea en 250-8.000 Hz; normal ≤20-25 dB.
- Conductiva: vía ósea normal, vía aérea descendida (gap aéreo-óseo). Sensorioneural: ambas descendidas sin gap. Mixta: ambas descendidas con gap.
- Patrones: presbiacusia (caída bilateral en agudos), trauma acústico (muesca en 4 kHz), Ménière (caída en graves fluctuante).
- Grados: leve 26-40, moderada 41-60, severa 61-80 y profunda >80 dB.
- Hipoacusia asimétrica sensorioneural requiere RM; requiere cooperación (no útil en lactantes, usar PEAT/emisiones).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 136

Paciente con hipoacusia y tinnitus, examen otoneurológico normal. **¿Cuál es el examen a solicitar?**

A) Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral
B) Impedanciometría
C) RNM de ángulo pontocerebeloso
D) TAC de peñascos
E) Audiometría

Respuesta E. Ante hipoacusia con tinnitus, el primer examen es la audiometría: cuantifica la pérdida y dice si es de conducción o sensorioneural. La imagen y los potenciales evocados vienen después, según el resultado.

6.03.4.007 Emisiones otoacústicas

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 18.21 Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen objetivo, rápido e inocuo que evalúa función de células ciliadas externas; base del tamizaje auditivo neonatal.
- Presentes (pasa): cóclea funcional; ausentes (refiere): repetir y si persiste, PEAT para confirmar.
- Puede fallar por vérnix, OME o detritus en el conducto (falso positivo).
- No evalúa la vía retrococlear: neuropatía auditiva (hiperbilirrubinemia, UCI) puede tener emisiones normales; en ellos usar PEAT.
- Normal descarta hipoacusia mayor a 30-40 dB de origen coclear.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Respecto al uso de emisiones otoacústicas en el tamizaje auditivo neonatal, se discute en una reunión clínica de neonatología. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

A) Evalúan toda la vía auditiva hasta la corteza
B) Un resultado normal descarta toda hipoacusia, incluida la retrococlear
C) Requieren sedación profunda
D) Evalúan la función de las células ciliadas externas de la cóclea; son rápidas e indoloras, pero no detectan la neuropatía auditiva, por lo que en recién nacidos de UCI se prefieren los potenciales evocados
E) No se ven afectadas por líquido en el oído medio

Respuesta D. Las emisiones otoacústicas registran sonidos generados por las células ciliadas externas de la cóclea. Son un tamizaje rápido, no invasivo y sin sedación, pero se alteran con vérnix o líquido en el oído medio y no evalúan la vía retrococlear (neuropatía auditiva). En recién nacidos de UCI se usan potenciales evocados automatizados.

6.03.4.008 Impedanciometría básica

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 14.5 Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

QUÉ HAY QUE SABER

- Timpanometría: mide la compliance del sistema tímpano-osicular según presión del conducto.
- Curva A: normal; As: rigidez (otoesclerosis); Ad: hipermovilidad (disrupción de cadena); B: plana (efusión o perforación); C: presión negativa (disfunción tubaria).
- Curva B con volumen normal: OME; curva B con volumen aumentado: perforación o colleras permeables.
- Reflejo estapedial: ausente en patología conductiva, otoesclerosis o lesión del VII par.
- Útil en niños para confirmar otitis media con efusión y su seguimiento.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

¿Cuál de las siguientes curvas de la clasificación de Jerger en la timpanometría se asocia de forma característica a la presencia de líquido seroso intratimpánico en la otitis media con efusión? **¿Qué curva corresponde?**

A) Curva A (pico centrado a 0 daPa con amplitud normal)
B) Curva As (amplitud disminuida con presión normal)
C) Curva B (curva aplanada sin punto de máxima compliance)
D) Curva C (pico desplazado a presiones negativas menores a -100 daPa)
E) Curva Ad (amplitud muy aumentada por discontinuidad de cadena)

Respuesta C. La curva B es plana, sin pico, porque el líquido del oído medio impide que el tímpano se mueva. La A es normal, la As indica rigidez como en la otoesclerosis, la C indica presión negativa por disfunción tubárica y la Ad indica disyunción de la cadena.

6.03.4.009 Polisomnografía

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)

QUÉ HAY QUE SABER

- Estándar diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño: registra EEG, oximetría, flujo, esfuerzo respiratorio, ECG y posición.
- Índice apnea-hipopnea (IAH): leve 5-15, moderado 15-30 y severo >30 eventos/hora en adultos; en niños ≥1 es anormal.
- Diferencia apnea obstructiva (esfuerzo presente) de central (sin esfuerzo).
- Poligrafía domiciliaria es alternativa en adultos con alta probabilidad sin comorbilidad mayor.
- Guía tratamiento: CPAP en moderado-severo; en niños con hipertrofia adenoamigdalina, cirugía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años, IMC 36 kg/m2, hipertenso con 3 fármacos, con ronquido intenso, pausas respiratorias presenciadas por su pareja y somnolencia diurna (Epworth 15). Sin enfermedad cardiopulmonar ni neuromuscular significativa. **¿Cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico?**

A) Polisomnografía (o poligrafía respiratoria domiciliaria en alta probabilidad), que permite calcular el índice de apnea-hipopnea
B) Espirometría
C) Gases arteriales en vigilia
D) Ecocardiograma
E) TAC de cuello

Respuesta A. La polisomnografía nocturna es el estándar para el diagnóstico de SAHOS: registra EEG, flujo, esfuerzo, saturación y otras variables, y permite calcular el índice de apnea-hipopnea (IAH: 5 a 14 leve, 15 a 29 moderado, 30 o más grave). En pacientes con alta probabilidad clínica y sin comorbilidad relevante, la poligrafía domiciliaria es una alternativa válida.

6.03.4.010 Pruebas cutáneas de alergia

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 14.9 Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

QUÉ HAY QUE SABER

- Prick test: identifica sensibilización IgE mediada a alérgenos inhalantes (ácaros, pólenes, epitelios, hongos) o alimentarios.
- Positivo: pápula ≥3 mm mayor que el control negativo; requiere control positivo (histamina) y negativo (suero).
- Suspender antihistamínicos 5-7 días antes; los corticoides tópicos nasales no interfieren.
- Positividad indica sensibilización, no necesariamente alergia: debe correlacionarse con la clínica.
- Indicaciones: rinitis persistente moderada-severa, mal control, para dirigir control ambiental o inmunoterapia. Alternativa: IgE específica sérica.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 25 años con rinitis persistente con estornudos, prurito nasal y rinorrea acuosa. Se solicitan pruebas cutáneas de alergia (prick test) para identificar alérgenos. **¿Cuál de los siguientes fármacos debe suspenderse días antes del examen porque produce falsos negativos?**

A) Corticoide intranasal
B) Antihistamínicos orales (por ejemplo, loratadina o cetirizina)
C) Paracetamol
D) Lavados nasales con suero fisiológico
E) Anticonceptivos orales

Respuesta B. El prick test detecta sensibilización mediada por IgE con alta sensibilidad; se usa control positivo (histamina) y negativo. Los antihistamínicos H1 suprimen la roncha y deben suspenderse alrededor de 5 a 7 días antes, al igual que algunos antidepresivos tricíclicos. Los corticoides intranasales no interfieren. Un resultado positivo debe correlacionarse con la clínica.

6.03.4.011 Estudio de VIII par

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 14.6 Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Evalúa porción coclear (audiometría, logoaudiometría, PEAT) y vestibular (pruebas calóricas, videonistagmografía, VHIT).
- Lesión retrococlear (neurinoma): hipoacusia asimétrica, mala discriminación verbal desproporcionada y PEAT con latencias prolongadas.
- RM con gadolinio es el examen definitivo para neurinoma del acústico.
- Pruebas calóricas: hipofunción unilateral en neuronitis vestibular, Ménière o neurinoma.
- El médico general debe interpretar el informe y derivar ante hipoacusia sensorioneural asimétrica, vértigo crónico o tinnitus unilateral.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 45 años con hipoacusia súbita del oído izquierdo de 2 días, con tinnitus y sensación de oído tapado. Otoscopía normal. Weber lateraliza a la derecha y Rinne positivo bilateral. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Lavado de oídos
> **B)** Antibiótico oral
> **C)** Audiometría urgente, corticoides sistémicos precoces y resonancia magnética de conductos auditivos internos con gadolinio para descartar patología retrococlear
> **D)** Observación por 1 mes
> **E)** Descongestionante nasal
> Respuesta C. Weber hacia el oído sano con Rinne positivo indica hipoacusia sensorioneural del oído afectado. La hipoacusia sensorioneural súbita es una urgencia: se confirma con audiometría, se inician corticoides sistémicos precozmente y se estudia el VIII par con resonancia con gadolinio por la posibilidad de schwannoma vestibular. El estudio puede complementarse con potenciales evocados auditivos.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 14 códigos

6.03.5.001 Drenaje de absceso mastoídeo

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 14.4 Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en mastoiditis con absceso subperióstico o falla del tratamiento antibiótico EV a las 48 horas; lo realiza ORL.
- El médico general debe reconocer: eritema y fluctuación retroauricular, pabellón desplazado, fiebre en contexto de OMA.
- Previo a derivar: hospitalizar, antibiótico EV (ceftriaxona), analgesia y TAC de oídos con contraste.
- Procedimientos: miringotomía con colleras, punción/drenaje del absceso o mastoidectomía cortical.
- Derivar de forma urgente si hay signos de complicación intracraneal (cefalea, meningismo, compromiso de conciencia).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un niño de 3 años, con otitis media aguda izquierda hace 10 días, presenta fiebre de 39 °C, tumefacción retroauricular fluctuante y pabellón auricular desplazado hacia adelante. Lleva 24 horas con ceftriaxona endovenosa. El TAC de peñasco con contraste muestra ocupación de las celdillas mastoídeas y un absceso subperióstico de 2 cm, sin complicaciones intracraneales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Cambiar a amoxicilina con ácido clavulánico oral y dar de alta
> **B)** Mastoidectomía radical con vaciamiento del oído medio
> **C)** Mastoidectomía simple con drenaje del absceso, miringotomía y mantener el antibiótico endovenoso
> **D)** Solo gotas óticas de ciprofloxacino
> **E)** Observar 7 días más con el mismo antibiótico, sin procedimientos
> Respuesta C. Un absceso subperióstico documentado es indicación de cirugía: mastoidectomía simple, cortical, con drenaje de la colección, junto con miringotomía para descomprimir el oído medio y cultivar, manteniendo el antibiótico endovenoso. La mastoidectomía radical es para el colesteatoma, no para la mastoiditis aguda.

6.03.5.002 Drenaje de absceso periamigdaliano

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 14.14 Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Técnicas: punción-aspiración con aguja (diagnóstica y terapéutica) o incisión y drenaje en el polo superior del pilar anterior.
- Se realiza con paciente sentado y anestesia local, evitando ir lateral o profundo por riesgo de lesión de la carótida interna.

- Previo a derivar: confirmar clínica (trismus, desviación de úvula, abombamiento), analgesia, hidratación y antibiótico.
- Tras drenaje: antibiótico (penicilina más metronidazol, clindamicina o amoxicilina-clavulánico) por 10-14 días.
- Hospitalizar si hay compromiso de vía aérea, deshidratación o mala respuesta; considerar amigdalectomía si recurre.

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 14.14

Un joven de 19 años con diagnóstico de amigdalitis aguda en tratamiento oral con amoxicilina desde hace 3 días consulta por agravamiento del cuadro. Presenta fiebre alta, odinofagia unilateral derecha intolerable, sialorrea profusa y marcada dificultad para abrir la boca. Al hablar se expresa con voz engorrosa apagada ('en papa caliente'). A la inspección orofaríngea se aprecia protrusión del pilar amigdalino anterior derecho con desplazamiento de la úvula hacia la izquierda. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico y terapéutico de elección que debe realizarse de inmediato?

A) Aumentar la dosis de amoxicilina oral al doble y asociar ketorolaco sublingual.
B) Punción con aguja o incisión y drenaje del espacio periamigdalino derecho e inicio de antibióticos endovenosos.
C) Solicitar tomografía computarizada de tórax ambulatoria para descartar masa tímica.
D) Intubación orotraqueal de urgencia y amigdalectomía bilateral en caliente inmediata.
E) Realizar laringoscopía indirecta con espejo para evaluar la movilidad de las cuerdas vocales.

Respuesta B. La opción correcta es la B. El cuadro clínico corresponde a un Absceso Periamigdalino derecho (quinsy), caracterizado por la tríada clásica de trismus, voz en papa caliente y desviación contralateral de la úvula provocada por la colección purulenta en el espacio periamigdalino. La conducta de elección que proporciona confirmación diagnóstica y alivio sintomático inmediato es la punción aspirativa con aguja o la incisión y drenaje en el punto de máxima fluctuación del pilar anterior, asociada al inicio inmediato de antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro con cobertura para anaerobios (Amoxicilina-Clavulánico o Penicilina + Metronidazol). Mantener tratamiento oral (opción A) es una conducta errónea ante una colección purulenta fascial.

6.03.5.003 Drenaje de absceso retrofaríngeo

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 14.14 Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Drenaje transoral (bajo anestesia general, posición de Rose con cabeza colgando) o cervical externo si hay extensión lateral; lo realiza ORL.
- Indicado en colección retrofaríngea confirmada por TAC con contraste, o fracaso del antibiótico EV a las 48-72 horas.
- El riesgo principal es la aspiración del pus por ruptura y obstrucción de vía aérea: manejo en pabellón con intubación controlada.
- Previo a derivar: estabilizar vía aérea, hospitalizar, ayuno, hidratación y antibiótico EV (ampicilina-sulbactam o clindamicina).
- Complicaciones a vigilar: mediastinitis, trombosis yugular y extensión al espacio prevertebral.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 3 años con fiebre alta, odinofagia, sialorrea, rechazo alimentario y tortícolis con dolor a la extensión del cuello, tras una infección respiratoria alta. La radiografía lateral de cuello muestra aumento del espacio prevertebral. La TAC con contraste confirma una colección retrofaríngea con realce periférico de 2,5 cm. Respira sin dificultad. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Antibiótico oral y control ambulatorio
B) Amigdalectomía de urgencia
C) Punción del absceso en el servicio de urgencia por vía externa
D) Corticoides y observación
E) Hospitalización, antibióticos endovenosos y drenaje quirúrgico (habitualmente transoral) por otorrinolaringología, con protección de la vía aérea

Respuesta E. El absceso retrofaríngeo predomina bajo los 5 años, por supuración de ganglios retrofaríngeos: fiebre, odinofagia, tortícolis o limitación de la extensión y espacio prevertebral aumentado. Se hospitaliza con antibióticos endovenosos (amoxicilina-clavulánico o clindamicina) y, si hay colección significativa, se drena en pabellón por vía transoral con la vía aérea protegida.

6.03.5.004 Drenaje de hematoma nasoseptal

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 14.12 Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

QUÉ HAY QUE SABER

- Drenaje urgente para evitar necrosis del cartílago septal y deformidad en silla de montar.
- Técnica (por ORL): incisión mucopericondral, evacuación de coágulos y taponamiento anterior bilateral o sutura transfixiante.
- Indicar antibiótico antiestafilocócico (cefadroxilo, amoxicilina-clavulánico) mientras dure el taponamiento.
- El médico general debe reconocer el hematoma (abombamiento blando y violáceo del tabique) en todo trauma nasal y derivar el mismo día.
- Control en 24-48 horas para pesquisar recolección o absceso septal.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Adolescente de 15 años recibe un golpe nasal jugando fútbol hace 24 horas. Presenta obstrucción nasal bilateral completa y dolor. La rinoscopía anterior muestra un abombamiento violáceo, blando y fluctuante a ambos lados del tabique. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Reducción de la fractura nasal en 7 días y antiinflamatorios
B) Corticoide oral
C) Descongestionante nasal y control en 48 horas
D) Drenaje urgente del hematoma septal, taponamiento nasal anterior bilateral y antibiótico
E) Esperar reabsorción espontánea

Respuesta D. El hematoma septal separa el mucopericondrio del cartílago, que depende de él para su nutrición. Sin drenaje urgente se produce necrosis del cartílago, absceso septal y deformidad en silla de montar. Se drena mediante incisión, se coloca taponamiento anterior para evitar la recolección y se indica antibiótico antiestafilocócico. Toda fractura nasal requiere examinar el tabique.

6.03.5.005 Drenaje de otohematoma

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 14.3 Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en hematoma del pabellón tras trauma; debe drenarse precozmente para evitar fibrosis y "oreja en coliflor".
- Técnica: punción-aspiración o incisión siguiendo los pliegues, en condiciones estériles, con evacuación completa del coágulo.
- Es esencial el vendaje compresivo o puntos de colchonero con almohadillas para evitar la recolección.
- Antibiótico profiláctico con cobertura antipseudomona (ciprofloxacino) y control en 24-48 horas.
- Derivar a ORL ante recurrencia, coágulos organizados o sospecha de pericondritis.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Se decide drenar en el servicio de urgencia un otohematoma de 12 horas de evolución en la cara anterior del pabellón auricular de un adulto. **¿Cuál es el paso más importante después de evacuar el contenido?**

A) Aplicar un vendaje compresivo moldeado al relieve del pabellón (o puntos de colchonero con soporte) para evitar la recolección, y control en 24 a 48 horas
B) Dejar el pabellón descubierto para vigilar
C) Aplicar calor local
D) Indicar gotas óticas
E) Cerrar la incisión con sutura continua hermética sin compresión

Respuesta A. El drenaje del otohematoma se realiza con técnica aséptica, bajo anestesia local, mediante punción-aspiración o incisión siguiendo los pliegues del pabellón. Lo más importante después es la compresión moldeada (gasas, férulas o puntos de colchonero transfixiantes con rollos) para que el pericondrio vuelva a adherirse al cartílago y no se reacumule la sangre. Se controla precozmente y se considera antibiótico.

6.03.5.006 Extracción de cuerpo extraño del oído

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 14.18 Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- Métodos: irrigación con agua tibia (solo objetos inertes no orgánicos y tímpano íntegro), pinza o gancho bajo visión directa, o aspiración bajo microscopio.
- Contraindicada la irrigación en pilas de botón, semillas o material vegetal y perforación timpánica.
- Insectos vivos: matarlos primero con aceite mineral o lidocaína.
- Objetos esféricos o impactados requieren gancho de punta roma o microscopio; múltiples intentos fallidos aumentan el riesgo de lesión.
- Derivar a ORL si falla un intento, hay lesión del conducto o el niño no coopera (puede requerir sedación).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 4 años con un poroto seco introducido en el conducto auditivo externo derecho hace 1 día. Coopera parcialmente. La otoscopía muestra el cuerpo extraño en la porción lateral del conducto, con tímpano no visible. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Lavado de oído con agua tibia a presión
B) Extraerlo con pinza de punta lisa empujando hacia adentro
C) Instilar gotas de agua para ablandarlo
D) Extracción bajo visión directa con gancho o cureta, pasando por detrás del objeto, o derivar a ORL si no coopera o el objeto está en la porción medial
E) Esperar expulsión espontánea

Respuesta D. Los cuerpos extraños del oído se extraen bajo visión directa con gancho o cureta pasado por detrás del objeto, con el niño inmovilizado o sedado. Las semillas y granos no se lavan con agua porque se hinchan. Las pinzas pueden empujar objetos redondos hacia el tímpano. Las pilas de botón son una urgencia.

6.03.5.007 Extracción de cuerpo extraño nasal

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 14.18 Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- Preparar con vasoconstrictor y anestésico tópico, buena luz y especulo nasal; inmovilizar al niño.
- Técnica de presión positiva: un padre sopla en la boca del niño ocluyendo la fosa contralateral ("beso de la madre").
- Usar gancho romo pasado por detrás del objeto para traccionar hacia adelante; evitar pinza en objetos redondos.
- Pila de botón o imanes: extracción urgente por riesgo de perforación septal.
- Derivar a ORL si es posterior, no se visualiza bien o falla un intento (riesgo de aspiración a vía aérea).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 3 años con rinorrea purulenta, fétida y unilateral derecha de 2 semanas que no ha mejorado con antibióticos. A la rinoscopía anterior se ve un objeto plástico en la fosa nasal anterior derecha. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir antibióticos por 10 días
B) Extracción del cuerpo extraño bajo visión directa con gancho romo o pinza, previa vasoconstricción tópica, o con técnica de presión positiva ("beso de la madre"), derivando si no se logra
C) Instilar suero para empujar el objeto hacia la faringe
D) TAC de cavidades perinasales y control
E) Lavado nasal a presión

Respuesta B. La rinorrea unilateral fétida en un niño es un cuerpo extraño nasal hasta demostrar lo contrario. Se extrae bajo visión directa con gancho romo o pinza, con vasoconstrictor tópico e inmovilización, o con presión positiva por la boca ocluyendo la fosa contralateral. Empujarlo hacia atrás arriesga aspiración. Pilas de botón e imanes son urgentes.

6.03.5.008 Intubacion traqueal

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: falla en proteger vía aérea (Glasgow ≤8), insuficiencia respiratoria refractaria, paro cardiorrespiratorio, inestabilidad o vía aérea amenazada.
- Preparación: preoxigenar con O2 al 100% 3-5 minutos, posición de olfateo, aspiración, laringoscopio, tubo con cuff (7-8 mujer, 8-8,5 hombre) y guía.
- Secuencia rápida: inductor (etomidato 0,3 mg/kg o ketamina 1-2 mg/kg) más relajante (succinilcolina 1-1,5 mg/kg o rocuronio 1,2 mg/kg).
- Confirmar posición con capnografía (estándar), auscultación de ambos campos y epigastrio, y radiografía de tórax.
- Si no se logra intubar ni ventilar: dispositivo supraglótico o cricotiroidotomía de urgencia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Se realiza intubación orotraqueal de un paciente con insuficiencia respiratoria en el servicio de urgencia. Tras pasar el tubo, se ausculta murmullo pulmonar solo en el hemitórax derecho y la capnografía muestra curva presente con valores adecuados. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Retirar el tubo y reintubar porque está en el esófago
B) Mantener sin cambios
C) Avanzar más el tubo
D) Instalar drenaje pleural izquierdo de inmediato
E) Desinflar el cuff y retirar el tubo unos centímetros hasta auscultar murmullo bilateral, y confirmar con radiografía de tórax

Respuesta E. La capnografía con curva persistente confirma ubicación traqueal. El murmullo solo derecho indica intubación selectiva del bronquio principal derecho por tubo muy profundo: se desinfla el cuff, se retira hasta lograr murmullo simétrico y se fija (adulto, unos 21 a 23 cm en la comisura). La radiografía confirma la punta 2 a 4 cm sobre la carina.

6.03.5.009 Laringoscopía indirecta

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 14.16 Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke

QUÉ HAY QUE SABER

- Visualización de laringe e hipofaringe con espejo laríngeo y luz frontal; hoy reemplazada mayormente por nasofibroscopía.
- Indicaciones: disfonía >3 semanas, odinofagia o disfagia persistente, otalgia refleja, sospecha de cuerpo extraño o cáncer.
- Evalúa movilidad de cuerdas vocales, lesiones (nódulos, pólipos, leucoplasia, tumor) y senos piriformes.
- Contraindicada en sospecha de epiglotitis en niños por riesgo de laringoespasmo.
- El médico general debe derivar a ORL para el examen y emplear su informe.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 58 años, fumador, consulta en un servicio de urgencia rural por disfonía de 5 semanas. No hay nasofibroscopio disponible, por lo que decides examinar su laringe mediante laringoscopía indirecta con espejo laríngeo. **¿Cuál es la técnica correcta?**

A) Paciente en decúbito supino con el cuello flectado y el espejo frío
B) Pedir al paciente que trague durante el examen para ver las cuerdas vocales
C) Introducir el espejo hasta apoyarlo en la pared posterior de la faringe para ver mejor
D) Paciente sentado e inclinado hacia adelante, lengua traccionada con una gasa, espejo entibiado apoyado en la úvula y el velo, pidiéndole que diga «i»
E) Si la laringoscopía indirecta es normal, se descarta un cáncer laríngeo y no requiere derivación

Respuesta D. En la laringoscopía indirecta el paciente se sienta erguido e inclinado hacia adelante; se tracciona la lengua con una gasa, se entibia el espejo para que no se empañe y se apoya en la úvula, sin tocar la faringe, para no gatillar náuseas. Al decir «i» las cuerdas se aducen. Una disfonía persistente en fumador igual se deriva a otorrinolaringología.

6.03.5.010 Lavado de oídos

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 14.3 Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado para remover tapón de cerumen; antes, reblandecer con gotas (agua oxigenada diluida, bicarbonato o aceite) por 3-5 días.
- Contraindicaciones: perforación timpánica conocida o sospechada, cirugía de oído previa, otitis externa o media aguda, colleras, pilas o semillas.
- Técnica: agua a temperatura corporal (37 °C) para evitar vértigo calórico; traccionar el pabellón hacia arriba y atrás; dirigir el chorro a la pared posterosuperior.
- Detener si hay dolor, vértigo o sangrado; secar el conducto y revisar tímpano al finalizar.
- Complicaciones: perforación, otitis externa, vértigo; derivar si el tapón no sale o hay complicación.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 60 años con hipoacusia derecha de 1 semana. La otoscopía muestra un tapón de cerumen que ocluye el conducto. Se planifica lavado de oído. **¿Cuál de los siguientes antecedentes contraindica el lavado?**

A) Antecedente de perforación timpánica o cirugía de oído
B) Hipertensión arterial
C) Uso de audífonos
D) Edad mayor de 60 años
E) Tapón de cerumen duro

Respuesta A. El lavado de oídos con agua a temperatura corporal (para no provocar vértigo) es eficaz para tapones de cerumen. Está contraindicado ante perforación timpánica conocida o sospechada, cirugía otológica previa, otitis con otorrea, cuerpos extraños vegetales o pilas. El cerumen duro se ablanda antes con gotas cerumenolíticas.

6.03.5.011 Maniobra de Heimlich

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 18.8 Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicada en obstrucción completa de vía aérea por cuerpo extraño en consciente mayor de 1 año: no puede hablar, toser ni respirar, signo universal de asfixia.
- Si tose eficazmente: no intervenir, animar a toser.
- Técnica: por detrás, puño sobre el epigastrio (entre ombligo y apéndice xifoides), compresiones rápidas hacia adentro y arriba hasta expulsar o perder conciencia.
- Lactantes <1 año: 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácicas alternadas; embarazadas y obesos: compresiones torácicas.
- Si pierde la conciencia: iniciar RCP y revisar la boca antes de ventilar; no barrer a ciegas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 40 años se atraganta comiendo carne en un restaurante. Se lleva las manos al cuello, no puede hablar ni toser y se pone cianótico, pero sigue consciente. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Darle agua para que trague
B) Barrido digital a ciegas
C) Realizar compresiones abdominales subdiafragmáticas (maniobra de Heimlich) desde atrás, repetidas hasta expulsar el cuerpo extraño o que pierda la conciencia
D) Esperar a que tosa espontáneamente
E) Iniciar compresiones torácicas de inmediato aunque esté consciente

Respuesta C. Obstrucción grave de la vía aérea (no habla, no tose) en un adulto consciente: compresiones abdominales (Heimlich) desde atrás, con el puño sobre el epigastrio; algunas guías intercalan golpes interescapulares. En embarazadas y obesos, compresiones torácicas. Si pierde la conciencia, RCP. Si la tos es efectiva, solo estimularla. No hacer barrido digital a ciegas.

6.03.5.012 Taponamiento nasal anterior

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 14.11 Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en epistaxis anterior que no cede con compresión digital ni cauterización.
- Técnica: anestesia y vasoconstricción tópica, gasa con vaselina en capas desde el piso de la fosa, o tapón expansible (Merocel) lubricado.
- Mantener 48-72 horas; antibiótico profiláctico antiestafilocócico si se mantiene más de 48 horas (riesgo de shock tóxico).
- Si persiste sangrado hacia la faringe con tapón bien puesto: sospechar epistaxis posterior y realizar taponamiento posterior.
- Indicaciones al alta: no sonarse, evitar esfuerzos, controlar presión arterial, control en 48 horas para retiro.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 45 años consulta por epistaxis izquierda activa de 30 minutos. Está hemodinámicamente estable. Se realizó compresión bidigital por 15 minutos con la cabeza hacia adelante y luego se dejó un algodón con vasoconstrictor, pero persiste el sangrado y con espéculo nasal no se logra ubicar el vaso sangrante. No cae sangre por la orofaringe. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Cauterización a ciegas con nitrato de plata de ambos lados del tabique
B) Ligadura quirúrgica de la arteria esfenopalatina
C) Taponamiento posterior con sonda Foley
D) Taponamiento nasal anterior con gasa vaselinada o Merocel por 48 horas
E) Inclinar la cabeza hacia atrás y dar de alta

Respuesta D. Si la compresión y el vasoconstrictor fallan y no se ubica el vaso para cauterizarlo, sigue el taponamiento anterior: gasa orillada con vaselina en capas hacia el piso de la fosa nasal, o Merocel, por 48 horas, con control ambulatorio. El taponamiento posterior se reserva para cuando falla el anterior y la sangre cae a la faringe.

6.03.5.014 Taponamiento nasal posterior

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 14.11 Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en epistaxis posterior que persiste pese a taponamiento anterior: sangrado a faringe, generalmente adulto mayor hipertenso.
- Técnica: sonda Foley (12-14 Fr) por la fosa hasta rinofaringe, inflar con 10-15 mL de agua o suero, traccionar hacia adelante y completar con taponamiento anterior.
- Fijar sin presión sobre el ala nasal (riesgo de necrosis); alternativa: balón de doble lumen.
- Hospitalizar: monitorizar oximetría (reflejo nasopulmonar e hipoventilación), antibiótico profiláctico, analgesia y control de PA.
- Retirar en 48-72 horas; si recurre, derivar a ORL para cauterización endoscópica o ligadura de esfenopalatina.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 9 años consulta en urgencia por sangrado nasal derecho activo tras hurgarse la nariz. Está hemodinámicamente estable. Se realiza compresión bimanual de las alas nasales durante 15 minutos continuos con cabeza hacia adelante, pero al soltar persiste sangrado leve. Al colocar un algodón con vasoconstrictor y retirarlo bajo buena luz con espéculo nasal, se visualiza claramente un vaso sangrante superficial en la porción anteroinferior del tabique nasal derecho. **¿Cuál es la conducta terapéutica de elección a continuación?**

A) Realizar taponamiento nasal posterior con sonda Foley de urgencia.
B) Cauterización química del vaso sangrante con bastón de nitrato de plata.
C) Indicar ácido tranexámico endovenoso y hospitalizar para observación.
D) Cauterización bilateral simultánea de ambas caras del tabique nasal.
E) Indicar al paciente mantener la cabeza inclinada hacia atrás durante las próximas 4 horas.

Respuesta B. Con el vaso identificado en el plexo de Kiesselbach, tras compresión y vasoconstrictor, corresponde cauterizar con nitrato de plata, de forma suave y concéntrica. Cauterizar ambos lados causa necrosis y perforación septal; la cabeza hacia atrás induce deglución de sangre; el taponamiento posterior y la hospitalización son desproporcionados.

6.03.5.015 Traqueostomía y cricoidostomía

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Cricotiroidotomía: vía aérea de emergencia ante situación "no intubo, no oxigeno"; se realiza a través de la membrana cricotiroidea.
- Por punción con aguja (preferida en menores de 10-12 años) o quirúrgica en adultos; es transitoria y debe convertirse a traqueostomía en 24-72 horas.
- Traqueostomía: procedimiento electivo para intubación prolongada (>7-14 días), obstrucción alta (tumor) o manejo de secreciones.
- Complicaciones: sangrado, enfisema subcutáneo, falsa vía, estenosis traqueal o subglótica.
- El médico general debe reconocer indicaciones y derivar; la traqueostomía la realiza el especialista.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 149

Paciente de 47 años con antecedente de neumonía grave por SARS-CoV-2 que requirió intubación y ventilación mecánica por 10 días evoluciona con dificultad respiratoria progresiva. Al examen físico presenta estridor bifásico, FC 110 lpm y FR aumentada a 20 rpm. La TAC de cuello muestra estenosis marcada de la vía aérea a nivel subglótico. **¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo actual?**

A) Intubación orotraqueal
B) Cricotirotomía
C) Traqueostomía
D) Oxigenoterapia por mascarilla de no recirculación
E) Broncoscopía

Respuesta C. La estenosis subglótica posintubación con estridor y dificultad respiratoria progresiva requiere una vía aérea segura por debajo de la estenosis: traqueostomía. La intubación es difícil y puede empeorar la lesión al pasar por la zona estrecha, y la cricotirotomía se realiza a nivel de la membrana cricotiroidea, justo en la zona estenótica subglótica, y es solo un procedimiento de emergencia.